

생명보험 파헤치기

고객의 종신보험 증권, 어떻게 읽고 어떻게 제안할까

2026년 최신 통계와 트렌드로 다시 쓴 「지피지기 백전백승」 편



2026 최신 통계



상품 해부



실전 화법



메리츠 솔루션

왜 지금, 다시 생명보험을 배워야 할까요?

판이 바뀌었습니다. 생보의 무기가 바뀌었고, 고객의 지갑 사정도 바뀌었습니다.



금리가 다시 오릅니다

2026년 8월 기준금리 3.00%, 정기예금 3.4%대. 생보의 「이자 붙는 보험」 화법이 되살아나는 시기입니다. 예금을 못 이기는 이유를 설명할 수 있어야 합니다.



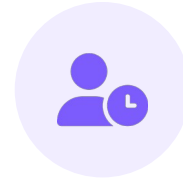
생보사가 손보 영역으로 들어왔습니다

종신보험이 안 팔리자 생보사들이 암·뇌·심장 「건강보험」을 주력으로 팝니다. 이제 경쟁 상대는 종신보험만이 아닙니다.



단기납 종신 열풍의 후폭풍

「10년 지나면 120% 돌려받는다」로 팔린 계약이 수백만 건. 이 고객들이 지금 보장분석 테이블에 올라옵니다.



초고령사회, 아픈 채로 사는 시간

기대수명은 늘었지만 건강수명은 그대로. 「사망」보다 「생존 중 치료비」가 진짜 리스크가 되었습니다.

오늘의 여정

생명보험을 해부하고 → 고객의 마음을 읽고 → 메리츠로 다시 설계합니다

01



판이 바뀌었다

2026 시장 지형도 · 통계

02



상품 해부학

이름만 봐도 아는 생보 상품

03



정면 비교

생보 vs 메리츠화재

04



고객의 마음

왜 종신보험을 가입했나

05



파훼법 5

거절을 녹이는 실전 화법

06



메리츠 솔루션

보장분석 → 제안 → 미션

07



만기까지

사망보장 1회 vs 생존보장 매년 ·
통합치료비

 **목표**
생보 증권을 만나면
「아싸」라고 말하기

보장분석 중 생명보험 증권을 만나면, 어떤 기분이세요?



"생소한데... 어떻게 이야기하지?"

- 상품명에 외계어 같다 (변액·유니버설·CI·달러...)
- 생보 설계사가 이미 「좋다」고 설득해 놓은 상태
- 괜히 건드렸다가 고객 기분만 상할까 걱정



"아싸! 잘 걸렸다!"

- 이름만 봐도 구조와 약점이 보인다
- 고객이 왜 가입했는지 3분 대화로 읽어낸다
- 사망은 정기로, 생존은 메리트 — 제안이 저절로 나온다

오늘 교육이 끝나면 왼쪽 얼굴이 오른쪽 얼굴로 바뀝니다. 생보 증권은 「위기」가 아니라 「가장 좋은 대화 소재」입니다.

워밍업 퀴즈 — "저는 사망하면 10억 나와요"

고객이 기억하는 건 숫자 하나. 약관이 기억하는 건 단서 조항 전부.

고객

FP님, 저는 옛날에 생보에서 가입해서요. 사망하면 10억 나옵니다. 더 필요 없어요.

FP

오, 든든하시겠어요! 그런데 혹시 그 10억이 「언제, 어떤 상황」의 사망인지 증권에서 같이 확인해 볼까요?

고객

...확인해 보니 「평일에, 대중교통 버스를 이용하다가, 사고로」 사망하면 10억이네요. 일반 사망은 5천만원이고요.



"사망하면 10억"과 "평일 대중교통 사고로 사망하면 10억"은 완전히 다른 보험입니다.

좋은 보험의 정의는 단순합니다. 단서 조항이 적고, 명확하고, 보험금 받기 쉬운 보험. 오늘 우리는 생보 증권의 「단서 조항」을 읽는 법을 배웁니다.

01

판이 바뀌었다

2026년, 숫자로 읽는 대한민국과 보험시장의 지형도



5명 중 1명이 65세 이상 — 초고령사회는 이미 도착했습니다

2024년 12월 23일, 65세 이상 인구 비율 20%를 넘어 「초고령사회」 진입. 세계에서 가장 빠른 속도입니다.

21.2%

65세 이상 인구 비율
(2025년 말 주민등록, 1,084만 명)

30% ↑

2036년 고령인구 비율 전망
2050년에는 40%를 넘습니다

8,604명

100세 이상 인구
(2025.11, 10년 전의 2.7배)

37.8%

고령자 가구 중 1인 가구
노인 3가구 중 1가구가 독거

이 숫자가 영업에 뜻하는 것

- 「오래 사는 위험」이 「일찍 죽는 위험」보다 커졌습니다 → 사망보장 중심 설계의 시대가 저물고 있습니다
- 독거 노인이 늘수록 간병·요양을 「돈으로 사야 하는」 사람이 늘어납니다
- 고객의 부모 세대가 이미 이 통계 안에 있습니다. 「부모님 간병」은 40~50대 고객의 현실 걱정입니다

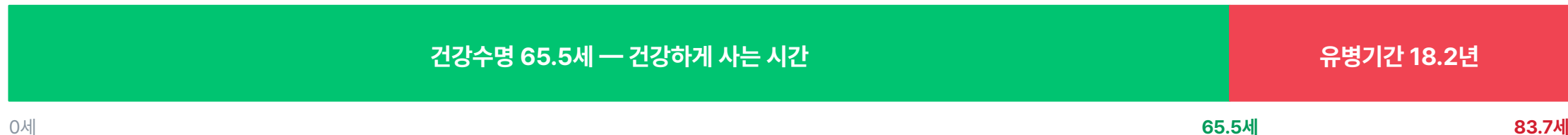
비유: 브레이크 없는 KTX

고령사회(14%)에서 초고령사회(20%)까지 프랑스는 39년, 일본은 11년, 한국은 단 7년이 걸렸습니다. 사회가 준비할 시간이 없었다는 뜻이고, 그 준비는 결국 개인의 몫이 됩니다.

83.7세까지 삽니다. 그런데 마지막 18년은 아픈 채로 삽니다

기대수명은 매년 늘지만 「건강수명」은 65.5세에 멈춰 있습니다. 보험이 일해야 하는 구간이 바로 이 18년입니다.

2024년 생명표 · 출생아 기준



남자: 기대수명 80.8세 · 유병기간 16.2년 | 여자: 기대수명 86.6세 · 유병기간 20.2년

19.5%

암으로 사망할 확률 (남 24.5%)

34.4%

40세 남성이 80세 전에 사망할 확률
= 3명 중 1명

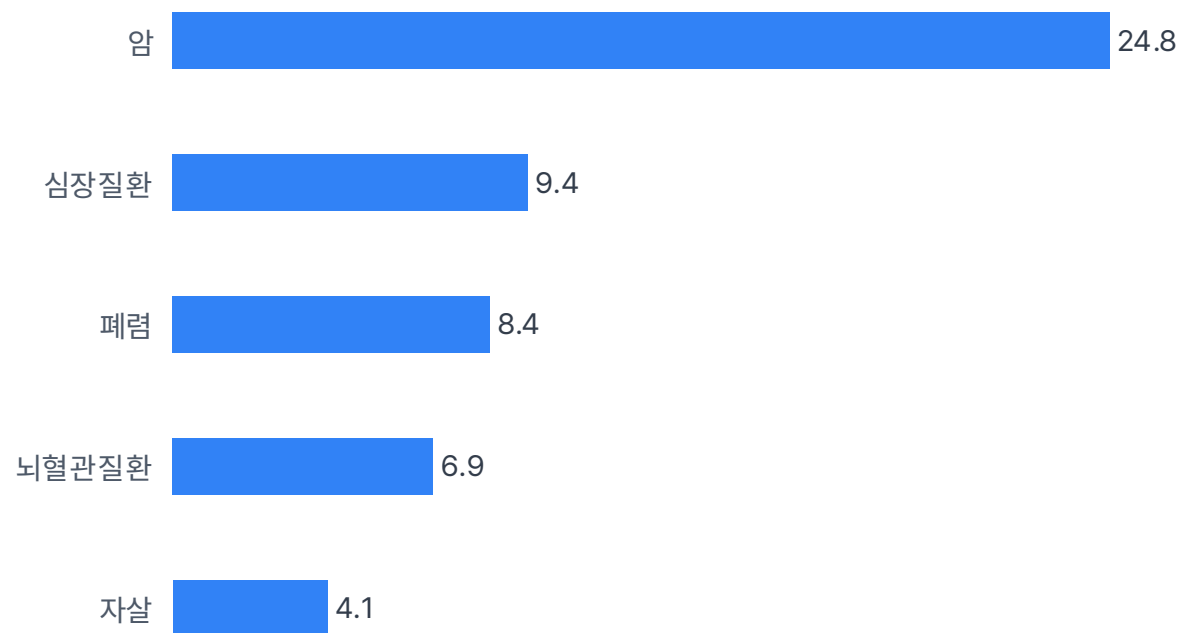
44.2%

남성이 3대 사인(암·심장·폐렴)으로
사망할 확률

사망의 92%는 병으로 옵니다 — 그리고 병은 「죽기 전에」 돈을 씁니다

2024년 사망자 35만 8,569명. 사고사는 8.3%뿐, 나머지는 질병입니다. 사망보험금 앞에 치료비·간병비 구간이 먼저 옵니다.

10대 사망원인 구성비 (2024, %)



40대의 충격

40대 사망원인 1위가 처음으로 「자살(26.0%)」이 되었습니다(암 24.5%). 50대는 암 34.5%. 경제활동 한가운데서 「갑자기」 무너지는 구조입니다.

화법

"우리나라 사람 대부분은 아파서 죽고, 그 다음이 힘들어서 죽습니다. 자살의 상당수는 돈 문제입니다. 사망보험금은 「죽고 나서」 나오지만, 병원비는 「살아 있는 동안」 나갑니다."

암은 「죽는 병」에서 「살아서 비용을 치르는 병」이 되었습니다

남자 2명 중 1명, 여자 3명 중 1명이 암에 걸리고, 10명 중 7명이 5년 이상 삽니다. 살아남은 사람에게 청구서가 옵니다.

44.6%

남성이 기대수명까지 살 때
암에 걸릴 확률 (여성 38.2%)

73.7%

암 5년 상대생존율
(2019~2023 진단자, 역대 최고)

273만 명

암 유병자 = 국민 19명 중 1명
신규 환자 연 28만 8,613명

10.7조

2024년 암 건강보험 진료비
항암제 청구액 3.1조(약품비 1위)

암종별 5년 생존율 — 격차가 곧 리스크

암종	생존율	암종	생존율
갑상선암	100.2%	대장암	75.6%
전립선암	96.9%	폐암	42.5%
유방암	94.7%	간암	40.4%
위암	78.6%	췌장암	17.0%

살아남은 뒤의 청구서

- 암 진단 후 직업활동 중단 53% (국립암센터) → 소득 공백
- 건보 암 보장률 75% → 나머지 25% + 비급여 + 간병은 본인 몫
- 1인당 생애의료비 중 암 1,937만원 (5대 질환 중 최다)
- 남성 암 1위가 「전립선암」으로 바뀜(2023) → 생보 소액암 분류 주의

출처: 보건복지부·중앙암등록본부 「2023년 국가암등록통계」(2026.1.20), 건강보험통계연보 2024(2025.11), 건보공단 생애의료비 연구(2025.12)

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

뇌와 심장 — 「터지는」 병보다 「막히고 좁아지는」 병이 압도적입니다

뇌졸중 연 11만 3천 건, 심근경색 연 3만 5천 건. 그런데 뇌졸중의 76%는 뇌출혈이 아니라 뇌경색입니다.



뇌

113,098건

2023년 뇌졸중 발생
1년 치명률 19.8% · 재발 25.3%

뇌경색(막힘) 76%

뇌출혈 24%

- 뇌혈관질환(I60~I69) 환자 117만 명(2022) vs 뇌출혈 환자 약 10만 명 → 「뇌출혈 진단비」만으로는 뇌혈관질환의 10%도 못 덮습니다
- 생존자 3명 중 1명은 영구 장애 (대한뇌졸중학회)
- 60세 이상이 환자의 약 80% — 부모 세대의 현실



심장

34,768건

2023년 심근경색 발생
1년 치명률 16.1% · 남성이 2.9배

협심증 등 허혈성심장질환 (좁아짐) 66.8만 명

AMI 12만

- 협심증 환자(66.8만)가 급성심근경색(12.1만)의 5배 이상(2020) → 「급성심근경색 진단비」만으론 심장질환 대부분이 빠집니다
- 급성심근경색 환자 최근 5년 +19.6%, 협심증 +6.0%
- 혈관질환은 반드시 「좁아지는」 전조 단계를 거칩니다

가장 슬픈 대출은 치료비·간병비 대출입니다

노후의 진짜 적은 「사망」이 아니라 「돈 드는 생존」입니다. 국민연금 평균 68만원으로 간병비 월 400만원을 감당할 수 없습니다.



하루 12~15만원

개인 간병인 일당 (2026, 종합병원 시세)
24시간 간병 월 300~450만원 · 사적 간병비 연 10조원



551만원

65세 이상 1인당 연간 진료비 (2024)
노인이 전체 건보 진료비의 44.9% 사용



1.85억 / 2.23억

남·여 1인당 생애의료비
그중 52%를 65세 이후에 씁니다



123.5만 명

장기요양 인정자 (2025), 급여비 17.7조원
치매 환자 2026년 100만 명 돌파



월 67~68만원

국민연금 노령연금 평균 수령액
20년 이상 가입해도 월 113만원



39.7%

66세 이상 노인빈곤율 — OECD 1위
(OECD 평균 14.8%의 2.7배)

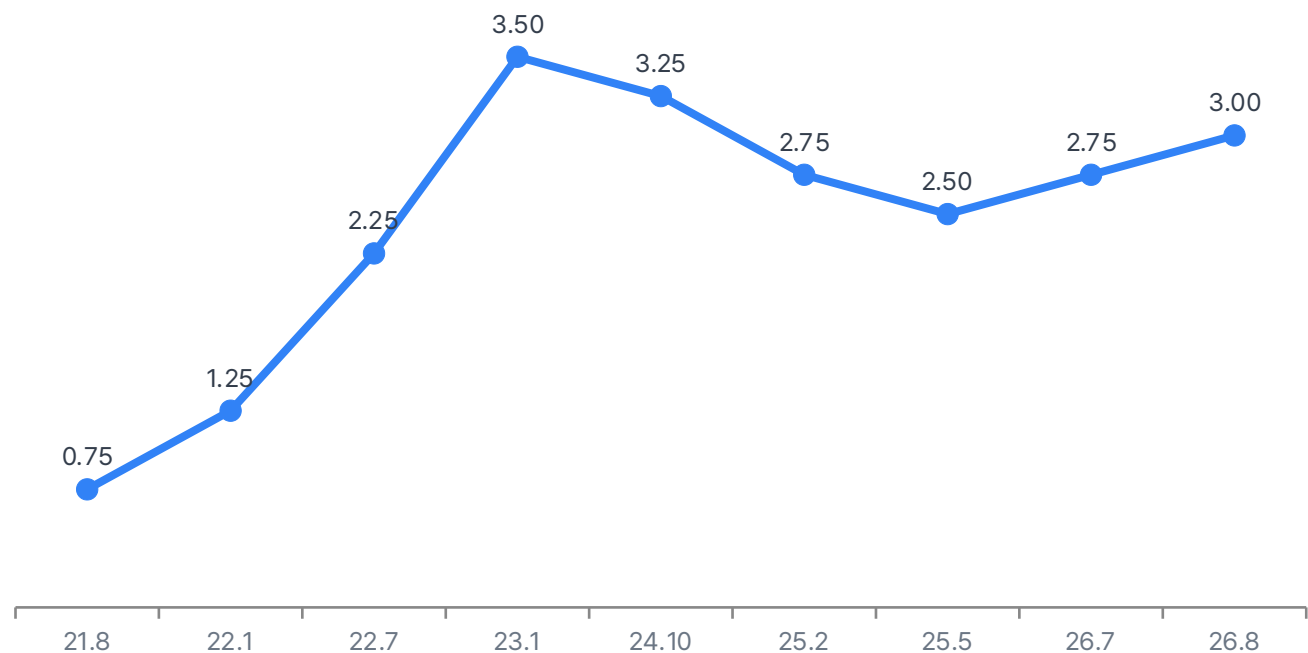


"대학병원·요양병원 지하에 뭐가 있는지 아세요? 은행 ATM과 대출 창구입니다." — 이 한 줄이 2026년 통계로 증명됩니다.

금리가 다시 오릅니다 — 「이자 붙는 보험」 화법이 되살아나는 계절

2026년 7·8월 연속 인상으로 기준금리 3.00%. 생보 설계사는 다시 「공시이율·환급률」을 꺼냅니다. 우리는 이렇게 답합니다.

한국은행 기준금리 추이 (%)



3.00%

기준금리 (2026.8.27)

3.30~3.45%

5대 은행 1년 정기예금 (2026.9)

2.50%

2026년 평균공시이율 (금감원 고시)

예금 3.4% vs 보험 공시이율 2.5%. 게다가 보험은 사업비를 뺀 나머지에만 이율이 붙습니다. 금리가 올라도 「보험으로 저축」은 예금을 못 이깁니다.

출처: 한국은행 금융통화위원회(2026.7.16 / 8.27), 은행연합회 소비자포털·5대 은행 공시(2026.9), 금감원 2026년 평균공시이율 고시(2025.12)

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

종신보험이 안 팔리자, 생보사가 우리 운동장으로 들어왔습니다

2026년 생보 신계약 -13%. 생보사 신계약의 주력은 이제 「암·뇌·심장 건강보험」입니다. 경쟁 상대가 바뀌었습니다.

-13%

2026년 상반기 생보 신규계약
보장성 초회보험료 -27.3%

200만 건

종신보험 신계약 건수 (2025)
2024년 217만 건에서 감소

+63.9%

생보 제3보험(건강) 초회보험료
2025년 7,582억원 (손보 9,291억)

85%

삼성생명 신계약 CSM 중
건강보험 비중 (2025년 2분기)

무슨 일이 일어나고 있나

- IFRS17 이후 「CSM(미래이익)」이 실적 지표 → 건강보험이 종신보다 수익성 배율 2~4배 (한화 16.4배 vs 종신 4배)
- 생보 GA 통합건강보험 시책률 2025.5 1,742% → 2026.9 최대 3,330%
- 한화 시그니처H(2026.1)·삼성 뇌심건강(2025.7)·교보(2024.3) 모두 뇌혈관·허혈성 특약 탑재

✂️ 우리에게 뜻하는 것

- 「생보는 뇌출혈만 판다」는 옛 화법은 위험합니다 — 신상품은 우리와 같은 담보를 팝니다
- 대신 고객이 「이미 가진」 종신·CI·GI 증권은 여전히 옛 구조(선지급·최초1회·사망 필수)
- 경쟁 포인트는 담보 이름이 아니라 「구조·납입면제·비갱신·보험료·관리」로 이동합니다

출처: 보험연구원 「2026년 보험산업 전망」(2025.10.21), 서울경제(2026.8.3), 파이낸셜투데이(2026.8), 한국경제(2026.4.19), 디지털타임스·녹색경제(2026), 보험저널(2025~2026), 한국금융신문(2025.6.15)

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

뉴스로 보는 「단기납 종신」 3년 — 136%에서 눈물까지

2024년 한 해 79만 8천 건이 팔렸습니다. 이 고객들이 지금 원금 도달 시점을 맞아 보장분석 테이블에 올라옵니다.



2026년 9월 환급률 (10년 시점)

5년납	7년납	10년납
121.0%	117.6%	113.5%

※ 2024년 초 136% → 절반 가까이 낮아진 매력

🎯 지금 만나는 고객 유형

- 2023~24년 가입 5·7년납 → 원금 도달 전, 해지하면 손실
- 「10년 뒤 120%」만 기억, 사망보장은 관심 없음
- 새 트렌드 「700종신(7년 100%)」 가입자도 등장

출처: 이데일리(2024.1), 머니투데이·한국경제(2024.3), 금융위 보험개혁회의(2024.11.4), 보험저널(2025.4/2026.1/2026.9), 파이낸셜뉴스(2026.5.29), 보험매일

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

설계사 71만 명 시대, 그러나 1년 뒤 남는 사람은 절반도 안 됩니다

「평생 관리해 드릴게요」라는 약속의 유효기간을 통계로 확인합니다. 종신보험은 특히 「관리」가 생명인 상품입니다.

38.2%

생보 전속설계사 13월차 정착률
(손보 46.4%, 2025년)

73.8%

보험계약 25회차 유지율 (2025)
4건 중 1건은 2년 안에 사라짐

2.8배

생보 불완전판매율 0.039%
vs 손보 0.014% (2025)

1위

생보 불완전판매 민원 중
종신보험이 최다 (금감원 2026.4)

뉴스 사례

- 대형 생보사 설계사 1,729명 GA 이동 → 전후 3개월 내 1만 2,935건 해지 (머니투데이 2025.12)
- 7개 대형 GA 설계사 408명, 2,984건 부당승환 적발 (금감원 2025.7)
- "보험료 낮춰주겠다"며 13건 해지·갈아타기 유도한 설계사 제재 (2026.2)

금감원 소비자경보 (2025.12.18)

"종신보험은 저축·연금상품이 아닙니다." — 저축성보다 위험보험료·사업비 차감이 커 목돈 마련에 부적합, 조기 해지 시 원금 손실, 연금전환 시에도 일반 연금보다 수령액이 적을 수 있음.

→ 우리 화법의 근거를 감독당국이 공식 문서로 써 준 셈입니다.

먹고살기 힘들 때 가장 먼저 깨지는 보험 — 종신보험

가계부채 2,000조 돌파, 물가 3%대, 대출금리 상승. 2026년 상반기 생보 해약환급금은 36.5조원으로 역대 최대입니다.

36.5조원

2026년 상반기 생보 해약환급금
전년 동기 25조 → +45%, 연간 사상 최대 전망

+32%

효력상실환급금 9,634억원
= 보험료를 못 내서 「실효」된 계약의 증가

2,019.8조

가계신용 잔액 (2026년 2분기, 사상 첫 2,000조)
소비자물가 2026.8 +3.1%

헤드라인으로 보는 2026

- "얹어진 지갑에 보험까지 깬다... 생보 해약환급금 급증"
- "보험 깨고 주식으로 우르르... 코스피 7000에 생보사 공공" (2026.5)
- "손해보고 도로 뺀 36조, 역대급" — 해지 많은 상품: 종신·암·연금 (2026.9)
- 보험계약대출 잔액 47.9조원(8개사, 2026.7) — 깨기 전에 빌리는 사람들

밑 빠진 독 비유

월 30만원 종신보험을 「저축」이라 믿고 5년 붓다가 생활비가 급해 깨면, 낸 돈 1,800만원 중 절반 이상이 사라집니다. 저축은 위기 때 꺼내 쓰라고 하는 건데, 종신보험은 위기 때 꺼내면 벌금을 내는 구조입니다. 이 고객이 지금 우리 앞에 앉아 있습니다.

출처: 연합뉴스(2026.9.2), 서울신문(2026.5.11), 머니투데이(2026.5.7), 서울경제(2026.8.11), 한국은행 가계신용(2026.8.19), 국가데이터처 소비자물가(2026.9.2)

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

Part 1 정리 — 2026년 생보 컨설팅의 5가지 전제

이 다섯 문장을 외우면 어떤 생보 증권 앞에서도 대화의 방향이 잡힙니다

1 사망보다 생존이 비싸다

기대수명 83.7세, 유병기간 18년, 간병비 월 400만원. 보험이 일할 곳은 「죽은 뒤」가 아니라 「아픈 동안」입니다.

2 좁은 담보는 통계로 반박된다

뇌졸중의 76%는 뇌경색, 심장질환 대부분은 협심증. 뇌출혈·급성심근경색만 보장하는 옛 증권은 확률의 절반 이상을 비웁니다.

3 금리가 올라도 보험은 예금을 못 이긴다

예금 3.4% vs 공시이율 2.5%, 사업비 차감 후 적용. 「이자 붙는 보험」 화법엔 숫자로 답합니다.

4 생보의 무기가 바뀌었다

신상품은 우리와 같은 건강보험. 고객이 「이미 가진」 종신·CI·GI의 옛 구조를 짚고, 새 경쟁은 구조·납면·비갱신·관리로 승부합니다.

5 관리 리스크가 통계로 증명됐다

생보 정착률 38%, 25회차 유지율 74%, 종신보험 민원 1위, 해약 36.5조. 「평생 관리」 약속의 유효기간은 짧습니다.

02

상품 해부학

이름만 봐도 구조와 약점이 보이는 생명보험 읽기



생명보험 상품 지도 — 크게 두 갈래, 그 아래 열 갈래

고객 증권의 상품명에 이 지도 위에 올려놓는 것이 컨설팅의 첫걸음입니다

생명보험 상품

저축성보험 · 「돈을 불리는」 목적

연금저축보험

세액공제형 연금

연금보험

비과세형 연금

저축보험

목돈·교육자금

변액연금

펀드 운용 연금

변액유니버설

펀드+자유입출금

보장성보험 · 「위험을 막는」 목적

종신보험

평생 사망보장

정기보험

기간 한정 사망보장

CI·GI 종신

중대질병 시 선지급

변액종신

펀드 운용 종신

생보 건강보험

암·뇌·심 진단 (신흥
주력)

상품명에 붙는 「옵션」 단어 — 금리연동형 / 변액 / 유니버설 / 무·저해지 / 단기납 / 체증형 / 달러

옵션이 붙을수록 보험료·비용 구조가 복잡해집니다. 「유니버설은 기능의 일부일 뿐」, 「보증비용 부과형은 보험료 ↑」 — 이 두 줄만 기억하세요.

이름 해부: 「무배당 통합 변액 유니버설 CI 종신보험」

외계어 같은 이름도 단어별로 쪼개면 구조가 보입니다. 이름 = 설계도



무배당

배당금을 주지 않는 상품. 현재 생·손보 거의 모든 상품이 무배당.



통합

하나의 증권에 사망·진단·수술·입원 담보를 「주계약 + 특약」으로 묶음.



변액

보험료 일부를 펀드(특별계정)에 투자. 수익률에 따라 보험금·환급금 변동.



유니버설

추가납입·중도인출·납입중지 기능. 「입출금 통장」처럼 들리지만 아님.



CI

중대한 질병·수술 시 사망보험금의 50~80%를 미리 지급(선지급).



종신보험

사망 시 지급, 보험기간은 피보험자가 죽을 때까지(종신).



고객에게: "고객님 상품 이름에 단어가 여섯 개나 있죠? 단어 하나마다 비용이 하나씩 붙어 있다고 보시면 됩니다."

종신보험의 뼈대 — 주계약 하나에 특약이 매달린 구조

내가 원하지 않아도 「사망」 주계약을 반드시 가져가야 합니다. 그래서 비쌉니다.

생보 통합종신보험의 구조

주계약: 사망보험금 (필수, 보험료의 대부분)
예) 1억 · 종신 · 20년납 → 월 25~30만원대

재해사망 특약

암진단 특약

뇌출혈 진단 특약

급성심근경색 특약

입원·수술 특약

납입면제 특약

- 특약은 대부분 5년·10년 「갱신형」 → 나이 들수록 보험료 상승
- 주계약이 해지되면 특약도 함께 소멸
- 사망담보가 필요 없는 고객에게는 구조적으로 비쌘

보험료 한 장을 쪼개 보면

위험보험료

저축보험료

사업비(부가보험료)

※ 비율은 상품·연령별로 다른 개념도(실제 비율 아님)

- **영업보험료 = 순보험료(위험+저축) + 부가보험료(사업비)**
- 초기 7~10년 사업비가 집중 차감 → 초기 해지환급금이 납입액보다 훨씬 적은 이유
- 「저축」이라 불려도 저축보험료 부분만 적립. 100% 저축이 아닙니다
- 무·저해지형은 이 저축보험료를 깎아 보험료를 낮춘 대신, 중도 해지 시 환급금 0~50%

이율 3형제 — 공시이율 · 예정이율 · 최저보증이율

생보 설계사의 「이자」 이야기는 대부분 이 세 단어에서 나옵니다



공시이율

은행 예금금리처럼 시중금리에 연동해 매월 바뀌는 「적립 이자율». 환급금이 이 이율로 붙어납니다. 금리 하락기에는 함께 떨어집니다.



예정이율

보험료를 계산할 때 회사가 「이 정도는 굴릴 수 있다」고 가정한 이율. 낮아지면 같은 보장의 보험료가 오릅니다.



최저보증이율

공시이율이 아무리 떨어져도 최소한 보장하는 이율. 요즘 상품은 대개 0.5~1%대(가입 후 기간별로 하락).

72의 법칙으로 감 잡기

원금 2배까지 걸리는 해 = $72 \div \text{이율}(\%)$.
금리가 올라도 보험 공시이율(2.5%)은 예금(3.4%)보다 낮고, 그마저 사업비를 댄 뒤 적용됩니다.

공시이율 1.5%

약 48년

2022년 최저금리 당시

평균공시이율 2.5%

약 29년

2026년 금감원 고시

정기예금 3.4%

약 21년

2026.9 은행 (참고)

「보증」이라는 단어에 붙는 가격표 — 보증비용 부과형

보험 안에 또 하나의 유료 보험이 들어 있습니다

1

최저사망보험금 보증비용

수익률이 나빠도 사망보험금을 지켜주는 대가

계약자적립금의 약 0.1% / 매년

2

최저해지환급금 보증비용

환급금 하한선을 지켜주는 대가

기본보험료의 약 3.5~4.0% / 매월 (납입기간 중)

3

최저연금적립액 보증비용

연금 재원 하한선을 지켜주는 대가

계약자적립금의 약 0.15~0.65% / 매년



케이크 위의 보험

변액상품은 펀드가 나빠지면 보험금도 줄 수 있어서, 「최소한 이만큼은 드립니다」라는 보증을 붙입니다. 그런데 그 보증은 공짜가 아닙니다.

매월 보험료의 3.5~4%가 「보증료」로 빠지면, 같은 보장의 미보증 상품보다 보험료가 비싸지고 환급금은 그만큼 덜 쌓입니다.

📌 증권에 「보증비용 부과형」이 보이면: "고객님, 이 상품은 매달 보험료의 약 4%를 보증료로 내고 계세요. 그 돈이면 암·뇌·심장 진단비 특약 하나가 들어갑니다."

유니버설 = 입출금 통장? 아니요, 「이자 붙는 현금서비스」입니다

기가 막힌 화법 세 가지와, 그 뒤에 숨은 조건 세 가지



추가납입

"보험료를 더 내면 환급금이 더 쌓여요"

기본보험료의 일정 배수 이내 등 한도 존재(상품별) · 추가납입에도 계약관리비용 부과



중도인출

"급전 필요하면 대출 없이 빼 쓰세요"

1회 해지환급금의 50% 이내, 연 12회 등 제한 · 인출하면 적립금↓ 사망보험금·환급금↓



납입중지

"형편 어려우면 잠시 멈추셔도 돼요"

의무납입기간(보통 2~10년) 이후만 가능 · 멈춘 동안 「월대체보험료」가 적립금에서 빠져나감

 월대체보험료 = 주계약 위험보험료 + 특약보험료 + 사업비. 납입을 멈춰도 「보험을 유지하는 비용」은 매달 적립금에서 계속 빠집니다. 적립금이 바닥나면 계약은 실효됩니다.

변액보험 — 내 보험료의 85~95%만 펀드로 갑니다

수익률이 다르니 민원도 많습니다. 달러종신은 환율 리스크까지 없습니다.



왜 민원이 많을까?

- 「펀드 수익률 = 내 수익률」이 아님. 투입 전 차감분을 먼저 회복해야 원금
- 펀드 변경·리밸런싱은 계약자가 직접 해야 하는데, 대부분 가입 후 한 번도 안 함
- 설계사가 떠나면 관리 공백. 10년 뒤 수익률표를 보고 그제야 놀람

💰 달러종신보험은?

보험료도 달러, 보험금도 달러. 환율이 오르면 매달 내는 원화 보험료가 늘고, 내릴 때 보험금을 받으면 원화 가치가 줄어듭니다. 「환테크」로 팔렸지만, 고객이 통제할 수 없는 변수를 보험에 얹은 셈입니다. Part 4의 실패사례 고객이 바로 「유니버설 달러 종신」 가입자입니다.

종신보험 변천사 — 금리와 규제가 만든 8세대

고객이 「언제」 가입했는지 알면 「무엇」에 혹했는지 보입니다



🔍 **증권의 「가입일」을 보세요. 2021~2024년 가입 = 단기납·환급률 화법 / 2015~2020년 = 무·저해지·최저보증 화법 / 2005~2014년 = 유니버설·연금전환 화법일 가능성이 큼니다.**

단기납 종신 「10년 뒤 120%」의 착시

환급률은 「이자율」이 아닙니다. 연 수익률로 바꿔 보면 다른 그림이 나옵니다.

예시: 5년납, 월 100만원, 10년 시점 환급률 120%

항목	금액
총 납입액 (60개월)	6,000만원
10년 시점 해지환급금	7,200만원 (120%)
차익	+1,200만원
연 환산 수익률(내부수익률)	약 2.6%
5년납 완료 직후 환급률	약 100% 안팎 (상품별 상이)
납입 중(1~4년차) 해지 시	무해지형 0원 · 저해지형 50% 수준

※ 2025년 이후 해지율 가정 강화로 신규 상품 환급률은 더 낮아진 추세. 강의 시 최신 상품설명서 수치로 교체.

꿀단지 비유

꿀단지에 5년 동안 꿀을 붓고, 뚜껑을 5년 더 닫아 두면 20% 더 늘어난다고 합니다.

그런데 ① 10년 안에 뚜껑을 열면 꿀이 절반 이하로 줄고 ② 10년 뒤 늘어난 20%는 연 2%대 이자와 같으며 ③ 그 사이 정말 필요한 「아플 때 꺼내 쓸 꿀(진단비·치료비)」은 단지 안에 없습니다.

종신보험은 사망보험금이 본질이고, 환급률은 「해지했을 때」 이야기입니다. 해지하면 보장은 사라집니다.

"나중에 연금으로 쓰세요" — 연금전환의 진실

틀린 말은 아닙니다. 그러나 「무엇을 잃는지」는 말하지 않습니다.

① 종신보험을 해지

해지환급금이 연금 재원이 됨

② 사망보장 소멸

주계약과 연계 특약도 함께 소멸

③ 연금액 계산

같은 보험료의 연금보험보다 적을 가능성 큼

왜 연금보험보다 적을까?

- 종신보험은 위험보험료·사업비가 커서 납입액 전부가 연금에 투자되지 않음
- 전환 시점 해지환급금 = 납입액의 70~100% 수준인 경우가 많음
- 전환 후엔 「종신연금」이 아닌 확정기간형만 가능한 상품도 있음

NEW 2025~ 사망보험금 「생전 활용」 제도

금융당국이 종신보험 사망보험금을 생전에 연금·요양 서비스로 바꿔 쓰는 「유동화」 제도를 도입했습니다. 그러나 이것 역시 「사망보험금을 깎아 쓰는」 구조입니다. 고객에게는 "결국 사망보장을 헐어서 생존자금을 만드는 거예요. 처음부터 생존보장을 따로 준비하는 게 맞습니다"라고 설명하세요.

CI보험 해부 — 「중대한」이라는 두 글자의 무게

중대한 질병·수술 시 사망보험금의 50~80%를 미리 주는 종신보험. 단, 나열된 것 중 가장 먼저 걸린 하나만, 최초 1회.

중대한 질병 8 + 중대한 수술 5 = 13개 (상품별 상이)

중대한 암

말기 신부전증

중증 재생불량성빈혈

대동맥 인조혈관치환술

중대한 화상·부식

중대한 뇌졸중

말기 간질환

루게릭병

심장판막수술

중대한 급성심근경색

말기 만성폐질환

관상동맥우회술

5대 장기이식수술

🎯 다트판 비유

다트판 정중앙(볼스아이)에 맞춰야 보험금이 나옵니다.

암에 걸려도 「침윤파괴적 증식」이어야 하고, 뇌졸중이 와도 「영구적 신경학적 결손 25% 이상」이어야 하고, 심근경색이 와도 「특정 효소 수치+심전도 변화+비가역적 괴사」가 동시에 확인돼야 합니다.

같은 병에 걸려도 「중대한」 문턱을 넘느냐로 0원과 수천만원이 갈립니다.

🎯 13개를 「전부 각각」 보장? 아닙니다. 가장 먼저 진단받는 하나에 대해 최초 1회만 지급, 이후 사망보험금은 선지급분만큼 줄어듭니다.

중대한 암 · 중대한 뇌졸중 · 중대한 급성심근경색

약관 문장을 그대로 읽어 드리는 것이 가장 강력한 화법입니다



중대한 암

- 악성종양세포가 존재하고 주위 조직으로 '침윤파괴적 증식'
- 제외: 악성흑색종 중 침범 1.5mm 이하
- 제외: 초기 전립선암, 초기 갑상선암
- 제외: HIV 관련 악성종양, 흑색종 외 피부암
- → 생보 일반 암특약도 생식기암은 소액암(10~20%)인 경우 다수



중대한 뇌졸중

- 뇌경색·뇌출혈 진단명만으로는 부족
- '영구적인 신경학적 결손'이 남아야 함
- 일상생활 기본동작에 25% 이상 장애
- 진단 후 일정 기간(예: 60일) 지속 확인
- → 후유장애가 남을 만큼 심각해야 지급



중대한 급성심근경색

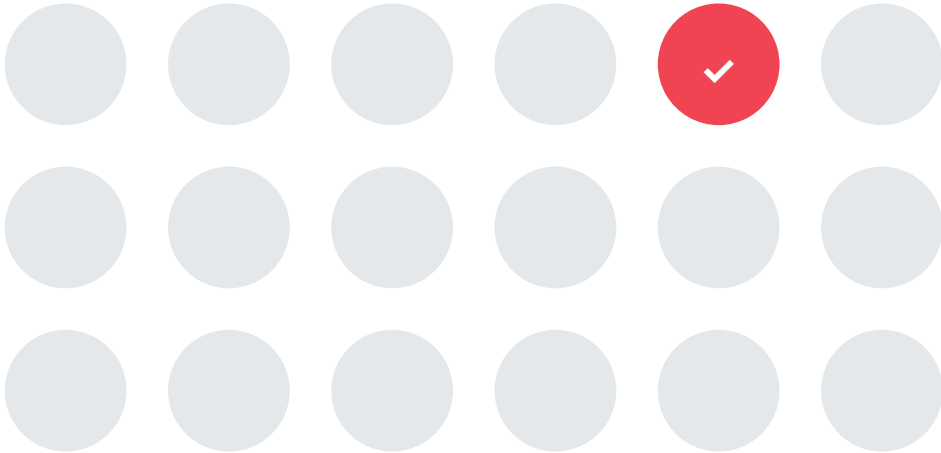
- 전형적 흉통 + 심전도의 새로운 변화
- 심근효소(CK-MB) 상승 동시 확인 — 트로포닌 제외 약관 다수
- 심근조직의 '비가역적 괴사'
- 급성기에 검사를 놓치면 확진돼도 부지급 가능
- → 협심증·스텐트 시술은 해당 없음

📖 전통적 CI 약관은 「CK-MB 포함 심근효소 상승(단, 트로포닌 제외)」 문구를 씁니다. 회사·가입시점별 약관이 다르니 해당 증권 약관을 반드시 확인하세요.

「최초 1회한」 vs 「각각 지급」 — 한 곳 차이, 천지 차이

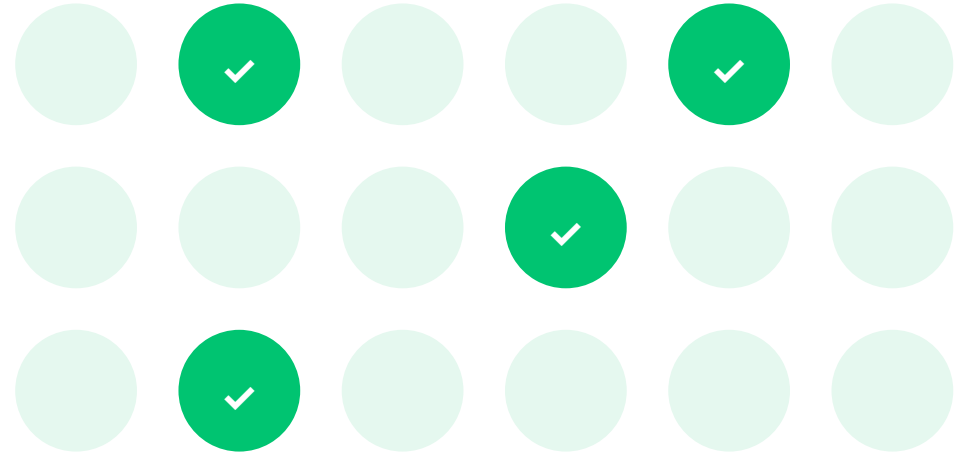
생보 통합 주계약은 18개 담보 중 하나를 받으면 나머지 17개가 사라집니다

생보 통합종신 주계약 (선지급형)



암 진단으로 1회 수령 → 이후 뇌졸중·심근경색이 와도 주계약에서는 추가 지급 없음.
사망보험금도 선지급분만큼 감소.

손보(메리츠) 통합건강보험 (특약 각각)



암 진단비 → 뇌혈관 진단비 → 허혈성 진단비 → 수술비... 특약마다 독립 지급. 하나를 받아도 나머지는 그대로 살아 있음.

GI보험 vs 메리츠 — 같은 사람이 같은 병에 걸리면 얼마를 받나

45세 남 · GI 종신 주계약 1억(선지급 80%) vs 메리츠 통합건강(암·뇌혈관·허혈성 각 3천 + 수술비) — 예시 시나리오

시점 · 사건	GI 종신보험 (주계약 1억)	메리츠 통합건강보험 (예시 설계)
47세 협심증 → 스텐트 시술	0원 (급성심근경색이 아니므로 GI 해당 없음)	허혈성심장질환 진단비 3,000만 + 수술비 이후 다른 담보 그대로 유지
50세 뇌경색	0원 (뇌출혈만 해당, 뇌경색은 제외)	뇌혈관질환 진단비 3,000만 + 수술비·입원일당 뇌졸중 진단 → 이후 보험료 납입면제
55세 위암	8,000만 선지급 (최초 1회한) 사망보험금 1억 → 2,000만으로 감소, 이후 GI 추가 지급 없음	암 진단비 3,000만 + 암 수술비 + 입원 다른 담보(뇌·심장·수술)도 계속 살아 있음
세 번 아픈 동안 받은 돈	8,000만 (한 번, 그것도 사망보험금 당겨 쓴 것)	9,000만 + 수술·입원 + 납입면제
월 보험료 (45세 기준 예시)	30만원대 (종신보다 약 40% 비쌈)	10만원대 (사망담보 제외 시)

화법

"고객님, 협심증으로 스텐트 넣으면 이 보험은 0 원이에요. 뇌경색도 0원. 암에 걸리면 8천만원 나오지만, 그건 고객님의 사망보험금을 미리 당겨 쓰는 거라 유족은 2천만원만 받습니다."

GI가 CI보다 나아진 점: 「중대한」 대신 진단코드로 지급, 뇌출혈은 진단만으로 OK.
그래도 남은 것: 뇌출혈·급성심근경색만, 최초 1회한, 선지급 후 사망보험금 감소.

🔑 GI는 「나열된 병 중 첫 번째 하나」에만, 「내 사망보험금을 미리 당겨」 줍니다. 메리츠는 「걸릴 때마다, 각각, 사망보험금과 별개로」 줍니다. 세 번 아픈 사람에게 어느 쪽이 보험일까요?

※ 진단비·보험료는 이해를 돕기 위한 예시이며 실제 지급액·보험료는 가입 설계와 약관에 따릅니다. 강의 전 당사 견적으로 갱신하세요.

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

「재해」와 「상해」는 같은 말이 아닙니다

생보 재해사망 1억 = 「재해분류표」에 해당하는 사고만. 손보 상해 = 급격·우연·외래의 사고 전부.

생보의 「재해」

- 약관 별표 「재해분류표」에 열거된 우발적 외래 사고만 인정 (S·T·V·W·X·Y 코드 기반)
- 제외 예: 질병·체질적 요인이 있는 사람의 경미한 외부 요인, 과로·격렬한 운동으로 인한 사고, 식중독 일부 등
- 재해 여부를 두고 분쟁이 잦음 — 「재해」인지 「질병」인지 의사 소견에 좌우

손보의 「상해」

- 「급격하고 우연한 외래의 사고」로 신체에 입은 상해 — 열거식이 아닌 포괄 정의
- 등산 중 넘어짐, 운동 중 인대 파열, 넘어져 골절 등 일상 사고 폭넓게 인정
- 상해 후유장애 3~100% 지급 등 생존 보장이 촘촘함

 사례: 마라톤 중 쓰러져 골절 — 생보는 「격렬한 운동」 제외 조항으로 다툼 소지, 손보는 급격·우연·외래 사고로 상해 인정 가능. 같은 사고, 다른 결과.

해지 말고 이 카드부터 — 종신보험 유지 옵션 4가지

고객 손해를 최소화하는 FP가 신뢰를 얻습니다. 「무조건 해지」는 하수입니다.



보험료 감액

보험가입금액을 줄여 보험료를 낮춤. 줄인 부분은 해지 처리(해지환급금 지급).



감액완납

더 이상 납입하지 않고, 지금까지 쌓인 환급금으로 살 수 있는 만큼 보장을 줄여 유지.



연장정기

보장금액은 그대로 두고, 환급금으로 유지 가능한 「기간」까지만 정기보험처럼 유지.



보험료 자동대출납입

환급금 범위에서 대출로 보험료 대신 납입. 이자 발생, 환급금 소진 시 실효.

 **판단 기준: 사망보장이 「아직 필요한 시기(자녀 독립 전)」면 감액·연장정기로 유지하고 절약분을 생존보장에, 필요 없는 시기면 감액완납으로 부담 0원 만들기.**

누가 내고, 누구 목숨에, 누가 받나 — 계약자·피보험자·수익자

40대 이상 고객이 「상속·증여 때문에 들었다」고 하면 반드시 이 세 칸을 확인하세요



계약자 = 부모 · 피보험자 = 부모 · 수익자 = 자녀

사망보험금이 상속재산에 포함 → 상속세 과세 대상

세금 발생 가능



계약자 = 자녀(소득 有) · 피보험자 = 부모 · 수익자 = 자녀

자녀가 자기 돈으로 낸 보험 → 원칙적으로 상속세 비과세

절세 구조



계약자 = 부모가 대신 납입 후 자녀 명의

실질 납입자가 부모면 증여로 봄 → 과세 가능

세금 발생 가능

👶 15세 미만은 사망을 담보로 하는 보험 가입 자체가 무효(상법 제732조). 어린 자녀를 피보험자로 한 종신은 없습니다.

🏛️ 상속세는 2026년 개편 논의(유산취득세·공제 확대)가 진행 중입니다. 세금은 「최신 세법 + 세무사 확인」을 전제로 안내하세요.

03

정면 비교

생명보험 vs 메리츠화재 — 같은 병, 다른 보험금



보험의 지도 — 4개의 방, 생보가 특화된 방은 하나뿐

「누가 받나(나·가족 / 남·타인)」 × 「언제 받나(살아서 / 사망 시)」로 나누면 보험이 한눈에 보입니다

보험금을 받는 대상: 나 / 가족

보험금을 받는 대상: 남 / 타인

살아있을 때
받는 보상

1

암·뇌·심 진단비 · 실손 · 수술비 · 입원일당 · 간병

생존 보장의 핵심. 생보·손보 모두 팔지만 손보는 특약 각각 지급·비갱신 100세·넓은 담보(뇌혈관·허혈성)가 강점. 생보 종신·CI·GI는 「사망보험금 선지급」 구조.

2

일상생활배상 · 운전자 · 자동차 · 화재배상

내가 남에게 끼친 손해를 대신 물어주는 보험. 오직 손해보험만 가능. 생보 증권에는 이 방이 통째로 비어 있습니다.

사망 시
받는 보상

3

사망보험 (종신·정기)

생명보험의 특화 영역. 그러나 「필요한 기간·필요한 금액」만 정기보험으로 준비하면 손보에서도 훨씬 싸게 가능. 종신은 이 한 방을 위해 가장 비싼 값을 치르는 상품.

4

존재하지 않음

내가 죽어서 남이 받는 보험은 없습니다. (자동차·배상책임의 대인 사망은 「살아있을 때 내 책임」 영역)

 **고객 워크: "고객님이 필요하다고 느끼는 방에 동그라미 쳐 주세요." — 대부분 1번과 2번에 그립니다. 생보 증권은 3번 방만 채우고 있습니다.**

구조 비교 — 담보 이름이 같아도 「설계도」가 다릅니다

2026년 생보 신상품이 뇌혈관·허혈성 특약을 팔기 시작했기에, 이제 승부는 담보명이 아니라 구조입니다

비교 항목	생보 종신·CI·GI (통합형)	메리츠 통합건강보험
사망담보	주계약 필수 — 원치 않아도 가져가야 함 (보험료의 대부분)	선택 — 필요한 기간·금액만 정기형으로, 또는 제외
진단비 지급 방식	사망보험금 선지급, 나열 질병 중 최초 1회한, 이후 사망보험금 감소	특약별 각각 지급 — 암 받아도 뇌·심장·수술비 그대로 살아있음
뇌·심장 범위 (기존 증권)	뇌출혈(I60~62) · 급성심근경색(I21~22) 중심	뇌혈관질환(I60~69) · 허혈성심장질환(I20~25)
암 분류	소액암(유방·전립선·자궁·방광 등) 10~20% 지급 상품 다수	유사암(갑상선·기타피부·경계성·제자리) 외 100%
특약 갱신	5·10년 갱신형 다수 → 나이 들수록 보험료 상승	비갱신 100세 만기 선택 가능
납입면제	암·뇌출혈·급성심근경색·80% 장애 등 3~4개	암·뇌졸중·급성심근경색·말기질환·50%↑ 후유장애 등 광범위
해지 시	초기 환급금 매우 낮음 (무·저해지형은 0~50%)	보장성이므로 환급 기대 없음 — 대신 보험료가 낮음

※ 회사·상품·가입시점별로 다릅니다. 고객 증권의 「약관·상품설명서」로 확인 후 안내하세요. 생보 신형 건강보험(2024~2026 출시)은 뇌혈관·허혈성 특약과 넓은 납입면제를 탑재한 경우가 있습니다.

같은 암에 걸려도, 가입한 회사에 따라 보험금이 다릅니다

남성 암 발생 1위가 전립선암(2023)이 된 시대에, 전립선암을 「소액암 20%」로 분류하는 증권이라면?

생보 (소액암 구분 상품)

일반암



소액암 (유방·자궁·전립선·방광 등)



유사암 (갑상선·기타피부·경계성·제자리)



예) 일반암 3,000만원 → 유방암 진단 시 300~600만원

메리츠화재

일반암 (유방·자궁·전립선·방광 포함)



유사암 4종



예) 일반암 3,000만원 → 유방암·전립선암 진단 시 3,000만원
감액기간 1년(50%) 이후 전액

근거: 2023년 남성 암 1위 전립선암, 여성 암 1위 유방암, 유병자 상위 갑상선·위·유방·대장. 「가장 흔한 암」이 「소액암」이면 진단비는 반토막의 반토막입니다.

출처: 2023년 국가암등록통계(2026.1.20), 생보 각사 암보험 상품 안내(2025~2026, 소액암 분류 존재), 손보 유사암 20% 이하 지급 관행(2022.10 금융당국 권고 이후)

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

뇌: 터진다 < 막힌다 < 좁아진다

고객 증권의 「뇌출혈 진단비」는 뇌혈관질환의 가장 좁은 문입니다. 뇌졸중의 76%가 그 문 밖에 있습니다.

뇌출혈 (I60~I62)

터진다

약 24%

생보 종신·CI·GI 주계약 및 옛 특약의 기준

뇌졸중 (I60~I63/I66)

터진다 + 막힌다

약 100%의 뇌졸중

뇌경색 포함 — 뇌졸중 발생의 76%가 여기서 추가

뇌혈관질환 (I60~I69)

+ 좁아진다·기타

환자 117만 명

메리츠 뇌혈관질환 진단비 특약 범위 (2022 환자 수 기준)

💬 "혈관은 갑자기 터지기 전에 반드시 막히거나 좁아집니다. 막히거나 좁아지는 것과 갑자기 터지는 것, 어느 쪽이 많을까요?"

▲ 2024~2026 생보 신형 건강보험은 뇌혈관질환 특약을 팝니다. 이 슬라이드는 「고객이 이미 가진 종신·CI·GI·구형 특약」에 적용하세요.

출처: 질병관리청 출혈성뇌졸중 등록사업(2023, 허혈 76.3% : 출혈 23.7%), 심평원 뇌혈관질환 진료현황(2022, 117만 명)

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

심장: 막힌다 < 좁아진다

급성심근경색 12만 명 vs 협심증 67만 명. 「급성심근경색 진단비」만 있는 증권은 심장질환의 5분의 4를 비워 둡니다.

급성심근경색 (I21~I22)

막힌다 · 심근 괴사

12.1만 명

생보 종신·CI·GI 주계약 및 옛 특약의 기준

허혈성심장질환 (I20~I25)

좁아진다 (협심증 I20 포함)

66.8만 명 + 12.1만

메리츠 허혈성심장질환 진단비 특약 범위 (2020 환자 수)

스텐트 시술의 함정

협심증으로 응급 스텐트를 넣어도 CK-MB가 정상이면 CI 「중대한 급성심근경색」 요건 미달 — 실제 분쟁 사례가 있습니다.

추세

급성심근경색 환자 최근 5년 +19.6%, 협심증 +6.0%. 둘 다 늘지만 「좁아진」 환자가 압도적 다수입니다.

화법

"고객님 증권은 심장이 「완전히 막혀서 근육이 죽어야」 나옵니다. 병원에서 협심증이라고 하면 0원이에요."

출처: 심평원 심장질환 진료현황(2020 기준 협심증 668,130명 · 급성심근경색 121,169명), 심평원(2024 발표) 5년 증가율, 한국보험신문 「중대한 문턱 높은 CI보험」(2026)

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

넓은 보장이 더 싸다 — 보험료로 보는 역설

「범위가 넓으면 비쌀 것」이라는 직관은 틀립니다. 특약 구조와 사망담보 유무가 가격을 결정합니다.

뇌·심장 특약 월 보험료 예시 (동일 조건 견적 비교 예시)

담보 (가입금액)	생보 A사	메리츠화재
뇌혈관(생보: 뇌출혈) 진단 3,000만원	50,100원	39,630원
뇌혈관 수술 1,000만원	3,500원	3,010원
허혈성(생보: 급성심근경색) 진단 3,000만원	52,110원	20,520원
허혈성 수술 1,000만원	3,520원	4,030원

왜 넓은데 더 싼까?

- 생보는 주계약(사망) 위에 얹는 특약 → 사업비 구조가 무거움
- 손보는 손해율 데이터 기반 특약 가격
- 사망담보를 빼면 총 보험료는 더 벌어짐

사망보장 자체도 — 40세 남 · 사망 1억 · 20년납

종신보험 (생보)

월 약 26만원

KB라이프 상품안내장 예시(2025~26)

정기보험 60세 만기

월 약 2.6만원

손보 정기형 예시 — 최신 견적으로 갱신

복층설계 (60세 1억 + 80세 5천)

월 약 7.6만원

복층 설계 예시 — 최신 견적으로 갱신

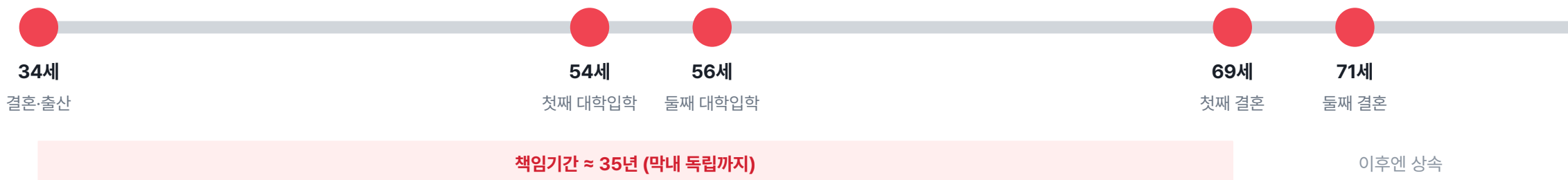
출처: 생보 A사 vs 메리츠 특약 견적 비교 예시, KB라이프 종신보험 상품안내장(40세 남 1억 20년납 월 26.2만원). 강의 전 당사 견적 시스템으로 최신 보험료를 넣어 사용하세요.

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

사망보장은 「평생」이 아니라 「책임기간」만큼

가장이 죽으면 곤란한 시기는 정해져 있습니다. 자녀가 독립하는 날까지. 그 뒤의 사망보험금은 상속이지 보장이 아닙니다.

고객 34세 · 배우자 27세 · 첫째 1세 · 둘째 출생 예정 (예시 가정)



종신 1억

월 약 26만원

평생 1억. 70세 이후 1억은 「보장」이 아니라 「상속». 40년 뒤 1억의 가치는?

정기 1억 (60세)

월 약 2.6만원

책임기간에 집중. 종신 대비 1/10 수준 보험료

복층 (60세 1억 + 80세 5천)

월 약 7.6만원

책임기간엔 두껍게, 이후엔 얇게. 절약분은 생존보장으로

납입면제 — 「아프면 보험료를 안 내도 되는」 조건의 넓이

보험료를 더 이상 내지 않고도 보장이 유지되는 납입면제. 어떤 병까지 인정하느냐가 회사마다 다릅니다.

생보 종신보험 (대표 사례)

암 (소액암·유사암 제외)

뇌출혈

급성심근경색

재해 80% 이상 후유장해

4개 안팎. 뇌경색·협심증·말기질환·질병 후유장해는 계속 보험료를 내야 합니다.

메리츠화재 통합건강보험 (예시)

암 (유사암 제외)

뇌졸중 (뇌경색 포함)

급성심근경색

상해·질병 50%↑ 후유장해

말기 폐질환·간경화·신부전

양성뇌종양·중증 재생불량성빈혈

희귀난치성 7대 질환·만성당뇨합병증

(상품별) 3대질환 진단 시 납면

11대 안팎(엠바스켓·더좋은엠바 기준). 「50% 후유장해」와 「뇌졸중」 포함이 결정적 차이.

💬 "보험료 더 이상 안 내는 납입면제라고 아세요? 고객님의 증권은 뇌경색으로 쓰러져도 보험료는 계속 내셔야 해요."

"보험은 병원 가는 순서대로 가입하는 것입니다"

진단 → 수술 → 입원 → 간병 → 회복 → (사망). 生에서 死로 가는 길목마다 손보의 담보가 서 있습니다.



🕒 "사망은 치료·입원·수술·간병을 받지 않아서 생깁니다. 살아서 병원 가는 모든 단계에서 돈이 나오는 보험이 손해보험이고, 마지막 단계에서만 나오는 보험이 종신보험입니다. 어느 쪽을 먼저 채워야 할까요?"

04

고객의 마음

왜 종신보험을 가입했을까 — 오픈북 테스트로 만드는 컨설팅



고객의 마음을 알면, 영업은 '오픈북 테스트'가 됩니다

고객이 왜 생보를 가입했는지, 생보 설계사가 어떻게 설명했는지 알면 — 네비게이션을 켜고 운전하는 것과 같습니다

네비 없이 운전

상품 지식만 들고 「이 상품 나빠요」로 시작. 고객은 방어 모드. 대화 3분 만에 "두고 가세요".

네비 켜고 운전

고객이 가입한 「이유·시기·기대」를 먼저 듣고, 그 지도 위에서 메리츠를 제안. 고객이 스스로 결론을 냅니다.

고객이 처음 종신보험을 가입한 이유는 단 하나: 「위험 보장」 — 나머지는 부수 옵션

그런데 고객이 말하는 「위험」과 우리가 말하는 「위험」이 다릅니다. 우리는 특정 질병·상해 담보를 위험보장이라 하지만, 고객이 생각한 위험보장은 「살면서 발생하는 변수」 — 남편의 조기 사망, 은퇴, 자녀 결혼, 간병 — 였습니다. 생보 설계사는 그 변수를 「종신보험 하나」로 다 막아준다고 그렸습니다. 우리가 할 일은 그 그림을 지우는 게 아니라, 그 그림을 「더 정확하게」 다시 그려 주는 것입니다.

생보 설계사는 무엇을 팔았나 — 「꿈 리스트」와 라이프사이클

생보 MDRT의 공식: 고객의 비재무적 목표를 꺼내고 → 일생에 대입하고 → 종신보험 하나로 해결해 준다고 약속한다

①

꿈 리스트 작성

"자녀 유학, 부부 크루즈 여행, 은퇴 후 전원생활..."
고객의 비재무적 목표를 종이에 적게 함

②

라이프사이클 대입

결혼·출산·대학·결혼·은퇴·간병 시점을 연표로 그리고
「돈 나갈 시점」을 표시

③

종신보험으로 해결

"이 하나로 사망도 막고, 중간에 빠져 자녀 결혼도 시키고, 남으면 연금으로" — 만능 뭉치돈 이야기

🔑 핵심 통찰

고객은 「종신보험」을 기대하고 가입한 게 아닙니다. 「보험으로 평생 날 도와줄 전문가」를 기대하고 가입했습니다. 고객이 산 것은 상품이 아니라 「관리해 주겠다는 약속」이었습니다. 그 약속의 유효기간이 통계로 얼마나 짧은지(생보 13월차 정착률 38.2%)는 Part 1에서 봤습니다. 우리가 그 자리를 대신하면 됩니다.

"아내에게 남편의 종신보험을 판다" — 생보가 그린 3단계 위험

수익자는 아내. 생보 설계사가 아내 앞에서 펼친 스토리를 그대로 재현합니다. 이걸 알아야 대화가 통합니다.



1단계 위험

조기사망

"자녀가 독립하기 전에 아빠 5명 중 1명은 떠납니다. 우리 남편이 그렇다면?" → 수익자를 아내로 한 종신보험

2026 통계: 40세 남성의 34.4%가 80세 전 사망, 40대 사인 1위 자살·2위 암



2단계 위험

은퇴 위험

"살아남은 4명에게 옵니다. 남편 은퇴 몇 년 뒤죠? 그때 자녀는 몇 살? 결혼은 시켜야죠" → 종신 환급금으로 해결

2026 통계: 국민연금 평균 월 68만원, 노인빈곤율 39.7%



3단계 위험

간병 파산

"여성의 미래입니다. 자녀에게 짐 지울 건가요? 당당한 노후 보내야죠" → 종신보험 연금전환

2026 통계: 간병비 월 300~450만원, 치매 100만 명, 유병기간 여성 20.2년

🎯 생보의 위험 인식 3가지는 모두 '맞는 걱정'입니다. 틀린 건 해결책(종신보험 하나)입니다. 걱정엔 동의하고, 해결책만 바꾸세요.

실패 사례 — 의욕이 앞선 컨설팅

배운 대로 열심히 설명했는데, 고객은 듣지도 않았습니다. 누구나 있는 흔한 경험담.

고객님이 가입한 [유니버설 달러 종신보험], 완전 손해 보는 상품이에요.

FP

고객

(뭐지, 부담스럽게) 아... 그런가요? 그거 좋다고 가입했는데.

이게 유니버설이 어찌고 달러가 저찌고 종신이 미주알 사업비가 고주알...

FP

고객

죄송한데 무슨 말인지 모르겠어요. 저는 이거 쪽 낼 생각입니다.

이 큰 돈 내고 계속 유지하시려고요? 제가 설계한 알뜰 플랜 보시면 암늬심에 수술비까지...

FP

고객

(지치게 하네...) 볼 테니 두고 가세요.

❌ 고객은 많은 고민 끝에 가입했고, 필요해서 유지 중입니다. 「상품 비판」으로 시작하면 고객은 「내 결정을 비판」당한다고 느낍니다.

「왜그그」 — 고객의 마음을 녹이는 대화 순서

왜? → 그 밖에 또? → 그래서! 종신보험 컨설팅 전에 반드시 거치는 3단계



왜?

1

가입 시점 상황 추리

고객 반응을 살피는 상황파악형 질문. 어떤 계기로(시기), 무엇에 혹해서(니즈), 무엇을 기대하고(솔루션) 가입했는지.



그 밖에 또?

2

기대한 점을 확실하게

즉각 반박하지 않고 더 듣기. 고객의 상황·견해·설계사와의 관계 등 중요 정보를 추가 획득. 타율을 높이는 과정.



그래서!

3

경청 후 논리적 정리

"정리하자면 ○○ 때문에 가입하셨군요. 그래서 오늘 인사드린 겁니다." 고객의 시야로 정리하고 제안으로 연결.



원칙: 고객의 부담감을 줄이는 법 = 「왜?」를 통해 고객이 많이 말하게 하기. FP가 말하는 시간이 30%를 넘으면 실패합니다.

① 왜? — 가입 시점에 있었던 일을 추리합니다

부담을 먼저 인정하고, 「어떤·무엇」으로 묻습니다

고객님, 제가 빙자고 했을 때 혹시 걱정되거나 불편한 부분 있으셨어요?

FP

고객

아 예... 뭐 조금 부담스럽긴 했어요. 잠깐이면 된다고 하셔서...

아! 혹시 무엇이 부담스러우셨어요? [왜? → 어떤/무엇]

FP

고객

지금 보험 내는 것도 많은데 또 권유하실까 봐 걱정이 좀 되었어요...

그럼에도 시간 내주셔서 감사합니다. 그때 이 보험은 어떤 말씀 듣고 가입 결정하셨어요? [왜? → 계기]

FP

✓ **포인트:** 부담을 「먼저」 꺼내 주면 고객이 방어를 품니다. 질문은 「왜 가입했어요?」(추궁)가 아니라 「어떤 말씀 듣고?」(상황).

② 그 밖에 또? — 고객이 보험에 기대한 점을 확실하게

반박하고 싶은 순간을 참으면, 고객이 「후회하는 지점」을 스스로 말해 줍니다

그 밖에 또 어떤 부분을 듣고 가입해야겠다고 확신하셨어요?

FP

고객

음... 기억은 잘 안 나는데, 중간에 돈 안 내도 되고 빠져 쓸 수 있다고 했어요.

아, 그렇군요. 혹시 그 외에 달러 환율이나 이런 것도 좋다고 들으셨어요?

FP

고객

아니요, 그건 못 들었어요. 요즘 가장 좋은 거고, 나중에 차 바꾸거나 이사할 때 돈 뺄 수 있다고 해서...

 얻은 정보: 고객이 산 건 「보장」이 아니라 「차 바꿀 때·이사할 때 뺄 돈」. 달러의 의미는 모르고 가입. 설계사 관리 없음.

 워크시트: 고객이 원한 것(비재무적 목표)과 실제 가입한 옵션(변액·유니버설·CI/GI/WI·달러)을 나란히 적어 보기 → 그 차이가 곧 컨설팅.

③ 그래서! — 고객이 거절해도 고객의 시야로 접근

거절은 「대화 종료」가 아니라 「정리의 시작」입니다

정리하자면, 보장도 되는데 돈 나갈 계획들을 종신보험 하나로 해결할 수 있다고 해서 가입하신 거군요.

FP

고객

네, 조금 부담스러워도 저축이거니 하고...

그래서 오늘 인사드린 겁니다. 부담스러운 보험을 부담스럽지 않도록요.

FP

고객

근데 전 아까 말씀드렸지만 보험 더 가입은 부담스러워요.

그래서 더 가입이 아니라, 지금 내시는 돈 안에서 「차 바꿀 돈은 차 바꿀 돈답게, 보장은 보장답게」 나누는 방법을 보여드리려고요.

FP

✓ 「그래서」 뒤에는 항상 고객의 말이 들어갑니다. 고객의 단어(차, 이사, 부담)로 제안하면 거절이 질문으로 바뀝니다.

"고객님은 ○○○이 고민되어 가입하셨군요"

보험에 대한 신뢰가 깨지면 보험은 의미가 없어집니다. 우리는 「생보를 깨는 사람」이 아니라 「고민을 이어받는 사람」입니다.

✕ 이렇게 말하면 진다

"그 상품 완전 손해예요" / "생보 설계사가 잘못 판 거예요" / "지금 당장 해지하세요"

✓ 이렇게 말하면 이긴다

"자녀 결혼자금에 고민이셨군요. 그 고민 그대로 두고, 방법만 더 효율적으로 바꿔 볼게요" / "종신보험도 좋은 보험입니다. 다만 저축·연금으로 쓰기엔 비효율적이어서요"

💎 "다이아 원석은 그냥 돌입니다. 가공해야 보석이 되듯, 종신보험도 필요할 때마다 적절하게 가공해야 도움이 되는 보험입니다. 문제는 그 가공을 누가 해 주느냐입니다."

05

파훼법 5

거절을 녹이는 실전 화법 — 통계와 비유로 무장한 다섯 가지 열쇠



파훼법 5가지 한눈에 보기

생보 설계사가 팔았던 「약속」 하나하나에 대응하는 열쇠입니다

1 설계사 관리 리스크

생보 화법: "평생 관리해 드릴게요"

우리 무기: 정착률 38%, 유지율 74%, 승환 1.3만 건

2 종신사망 무용론

생보 화법: "사망보험금이 가족을 지켜요"

우리 무기: 사망의 92%는 질병, 유병기간 18년

3 밑 빠진 독

생보 화법: "저축이에요, 빼서 쓰세요"

우리 무기: 해약환급금 36.5조, 상조 비유

4 단서조항 & 최초 1회한

생보 화법: "이 병 저 병 다 보장돼요"

우리 무기: 10억 버스, 다트판, 18개 중 1개

5 보험료 다이어트

생보 화법: "이 정도는 내셔야죠"

우리 무기: 종신 26만 → 정기 2.6만 + 생존보장

파훼법 1. 설계사 관리 리스크 — "고객님 혼자 못 씁니다"

종신보험은 「보장」이 아니라 「기능」을 써야 하는 상품. 그 기능을 평생 대신 만져 줄 사람이 있습니까?

스크립트

- "생명보험 단어만 들어도 어렵죠? 고객님의 혼자서는 못 쓰는 상품입니다."
- "고객님이 필요한 타이밍에 맞춰 추가납입·인출·감액·연금전환을 적절하게 해야 하는데, 과연 그 설계사님이 고객님의 평생을 관찰하는 게 가능할까요?"
- "생보 설계사 10명 중 6명이 1년 안에 그만둡니다(13월차 정착률 38.2%). 부업형 설계사가 늘면서 「고아계약」이라는 말까지 생겼어요."
- "유니버설 하나만 해도 이자율·인출금·월대체보험료·대체가능 적립금을 봐야 하고, 연금전환은 사망보장 공백·특약 소멸·보증이율·과세를 봐야 합니다. 하나하나 제대로 알아보고 쓰실 수 있으세요?"

2026 근거

- 생보 전속 13월차 정착률 38.2% (금감원, 2026.4)
- 대형 생보사 설계사 1,729명 이탈 → 1만 2,935건 해지
- GA 설계사 31.9만 명, 「고객 미아」 기사 다수(2026)

비유: 셀프 정비 스포츠카

종신보험은 옵션이 잔뜩 붙은 스포츠카입니다. 잘 타면 멋지지만 정비를 계속 해야 합니다. 그런데 정비사가 1년 만에 사라지고, 매뉴얼은 외계어입니다. 고객님은 지금 그 차를 「그냥 세워 두고 할부만」 내고 계신 겁니다.

파훼법 2. 종신사망 무용론 — "사망의 본질은 치료자금 부족입니다"

生에서 死로 가는 순서: 검사 → 진단 → 수술 → 입원 → 간병 → 사망. 사망보험금은 맨 마지막에만 나옵니다.

스크립트

- "우리나라 사람 92%는 병으로 죽습니다. 사고사는 8%뿐이에요."
- "암은 이제 중대질환이 아니라 만성질환입니다. 10명 중 7명이 5년 넘게 살고, 돈은 그동안 계속 나가요. 진단 후 53%가 일을 그만둡니다."
- "의학이 발달할수록 더 오래 살고 병원비는 더 많이 나갑니다. 평생 의료비 2억 중 절반이 65세 이후예요."
- "대학병원·요양병원 지하에 뭐가 있는지 아세요? 가장 슬픈 대출은 치료비·요양비 대출입니다."
- "사망보험금은 「죽고 나서」 나오지만, 병원비는 「살아 있는 동안」 나갑니다. 어느 쪽을 먼저 채워야 할까요?"

生 → 死 : 돈이 나가는 순서



생보 종신보험은 6번에서만, 손보 통합건강은 1~5번에서 지급

파훼법 3. 저축이 아닌 밑 빠진 독 — "적금 vs 상조, 뭐 드세요?"

종신보험으로 목돈 마련은 「상조로 재테크」와 같습니다. 옵션이 아무리 붙어도 상조는 상조입니다.

고객님, 목돈 마련하려고 하시면 적금이랑 상조 둘 중 어떤 걸 드세요?

FP

고객

당연히 적금 가입하죠. 왜 상조를 가입해요!

요즘 상조는 죽지 않아도 결혼자금·크루즈여행으로 전환된다는데요?

FP

고객

...그래도 상조는 상조죠.

맞습니다. 아무리 옵션이 있어도 상조는 상조일 뿐이죠. 종신보험으로 목돈 마련은 바로 「상조로 재테크」하는 것과 같습니다. 입출금통장처럼 빼서 쓴다고요? 그건 이자 붙는 현금서비스예요.

FP

 **2026: 생보 해약환급금 상반기 36.5조(+45%), 효력상실 +32%. "먹고살기 힘들 때 가장 취약한 보험 = 종신보험"이 숫자로 증명됐습니다.**

 금감원 소비자경보(2025.12.18): "종신보험은 저축·연금상품이 아닙니다." 순수저축 목적으로는 부적합 — 감독당국의 공식 문장을 그대로 보여 주세요.

파훼법 4. 단서조항 & 최초 1회한 — "좋은 보험은 단서가 없는 보험"

고객은 숫자 하나(10억, 5천만원)만 기억합니다. 약관은 조건 전부를 기억합니다.

10억 버스

"사망하면 10억"이 아니라 "평일 대중교통 사고로 사망하면 10억". 증권을 같이 펴고 「어떤 사망」인지 읽어 드리세요.

다트판

CI의 「중대한」은 불스아이. 암도 침윤파괴적이어야, 뇌졸중도 25% 장애가 남아야, 심근경색도 CK-MB가 올라야. 같은 병, 다른 결과.

18개 중 1개

통합 주계약 18개 담보 중 하나 받으면 17개 소멸. "심장 아프면 3천만원 나오는 줄" 아는 고객이 정말 많습니다.

스크립트

"고객님, 증권 같이 볼까요? 여기 「중대한」이라는 글자가 보이시죠. 이 두 글자가 붙으면 병원에서 암이라고 해도 보험사는 「중대한 암」인지 다시 봅니다. 그리고 이 13개 중에 제일 먼저 걸리는 하나만, 딱 한 번 나옵니다. 저희는 이 두 글자가 없고, 각각 나옵니다. 어느 쪽이 받기 쉬울까요?"

파훼법 5. 보험료 다이어트 — "더 내지 말고, 다시 나누세요"

"보험 더 가입은 부담스러워요"에 대한 유일한 정답: 지금 내는 돈 안에서 재배치

BEFORE — 40세 남, 월 30만원

종신 사망 1억 (20년납) 약 26만원

갱신했던 특약 몇 개 약 4만원

- 70세 이후 사망보험금 = 상속
- 뇌출혈·급성심근경색만, 최초 1회한
- 해지하면 손해, 유지하면 부담

AFTER — 같은 월 30만원

정기·복종 사망 (60세 1억 + 80세 5천) 약 7.6만

암·뇌혈관·허혈성 진단비 각 3천 약 10만

수술비·입원일당·간병 약 7만

배상책임·운전자·기타 약 3만

남는 돈 → 진짜 저축·투자 약 2.4만

* 예시 배분. 실제 설계는 당사 전산 견적으로.

💬 "고객님 돈을 더 쓰시라는 게 아니에요. 같은 30만원을 '죽어야 나오는 돈'에서 '아플 때 나오는 돈'으로 옮기고, 남는 2~3만원은 진짜 저축에 넣으시라는 겁니다."

상황별 대응 ① "해지하면 손해잖아요" / "10년만 지나면 120%예요"

해지를 권하지 않아도 됩니다. 유지 옵션과 숫자로 답하세요.

"해지하면 손해잖아요"

- "맞습니다. 그래서 해지하시라는 게 아니에요." — 먼저 동의
- 판단 기준: 사망보장이 아직 필요한 시기인가? (자녀 독립 전 = 필요)
- 필요하면 → 감액·연장정기로 유지 + 절약분을 생존보장에
- 필요 없으면 → 감액완납으로 부담 0원, 남은 보험료 전액 재배치
- 무·저해지형 납입 중이면 → 환급금 0~50%이므로 「납입 완료 시점」과 「원금 도달 시점」을 표로 같이 보기
- "고객님 손해를 제일 작게 만드는 게 제 일입니다"

"10년만 지나면 120%예요"

- "네, 10년 지나 해지하면요. 그런데 해지하면 보장은 사라지죠?" — 환급률은 해지 이야기
- 120%를 연 수익률로 바꾸면 약 2.6%. 지금 정기예금이 3.4%입니다(2026.9)
- 2026년 신규는 5년납 121%·7년납 117.6%로 낮아졌고, 원금 도달 뒤 80% 이상이 해지한다는 기사(2026.9)를 보여 주기
- 비과세 요건(5년납·10년 유지·월 150만원 규정 등)과 중도해지 손실을 함께 설명
- "10년 동안 아프면 어떻게 하죠? 그 사이 진단비는 이 보험에 없습니다"

상황별 대응 ② "변액·달러라 수익 나요" / "저 생보에서 건강보험 들었어요"

옛 무기가 안 통하는 두 상황. 2026년형 답변입니다.

"변액·달러라 수익 나요"

- "공시 수익률은 납입보험료가 아니라 「특별계정 투입금」 기준이에요. 사업비 뎀 85~95%가 먼저 수익을 내야 원금이죠"
- 달러종신: 2023년 1.2만 건 → 2025년 1~10월 9.5만 건 급증, 금감원 소비자경보 (2026.1) — "환율 전망은 보장이 아닙니다"
- "펀드 변경·리밸런싱, 마지막으로 언제 하셨어요?" (대부분 「한 번도」)
- "수익이 나는 건 좋은 일이에요. 그 수익을 지키려면 보장은 따로 있어야 합니다. 아르면 이 계좌에서 돈이 빠져나가거든요"

"저 생보에서 건강보험 들었어요"

- 옛 화법 금지: "생보는 뇌출혈만" — 2024~26 생보 신형은 뇌혈관·허혈성 특약을 팝니다
- 확인할 것 ① 진단비가 「각각 지급」인지, 주계약 선지급형인지
- 확인할 것 ② 특약이 갱신형인지(5·10년 갱신 → 보험료 상승), 비갱신 100세인지
- 확인할 것 ③ 소액암 분류·감액기간·납입면제 범위·유사암 정의
- 확인할 것 ④ 배상책임·운전자·간병 등 손보 전용 담보의 공백
- "좋은 선택 하셨어요. 빈 방(배상·간병·수술)만 저희가 채워 드릴게요" — 보완 제안으로

06

메리트 솔루션

보장분석 → 제안 → 미션: 내일 아침 현장에서 바로 쓰는 실행 패키지



메리츠 제안 프레임 — 사망은 정기, 생존은 통합건강, 책임은 배상

「나를 위한 보장」은 생명보험보다 메리츠화재. 세 문장으로 요약되는 설계 원칙

사망보장

가장의 책임기간까지
정기·복층설계

종신 1억 26만원 → 정기·복층 7.6만원. 70세 이후 1억은 상속이지 보장이 아닙니다.

생존보장

3대 진단비는 넓게
일반암·뇌혈관·허혈성

각각 지급 · 비갱신 100세 · 광범위 납입면제 · 수술비·입원·간병까지 病院 가는 순서대로.

책임보장

남에게 끼친 손해
배상책임·운전자

생보 증권에 통째로 비어 있는 방. 일상생활배상, 운전자 (벌금·변호사비·형사합의금).

✦ 당사 상품군 활용 예: 통합간편건강보험(유병자 3대질병 중심) · 케어프리보험 M-Basket(다담보 통합·간병) · 운전자상해종합보험(스쿨존 벌금 등) · 치아보험 — 정확한 담보·납면 조건은 현행 상품설명서 기준

생보 증권 보장분석 4단계 — 증권을 받는 순간부터 제안까지

영업포탈 보장분석과 연계해 「직접 확인하고 활용」하게 하세요

1 증권 수집 & 가입일 확인

가입 연도로 세대 판별(단기납? 무저해지? 유니버설?) · 계약자·피보험자·수익자 확인

2 이름 해부

상품명 단어를 쪼개 옵션·비용 구조 파악 (변액·유니버설·CI/GI·달러·보증비용)

3 4분면 매핑

사망/생존 × 나/남 4개 방에 담보를 배치 → 빈 방 찾기 (대부분 1·2번 방이 비어 있음)

4 갭 제안 & 유지옵션

보험료 다이어트표(BEFORE/AFTER) + 해지 대신 감액·감액완납·연장정기 안내

📋 체크리스트: ☐ 가입일 ☐ 계약자/피보험자/수익자 ☐ 주계약 유형 ☐ 특약 갱신 여부 ☐ 납입면제 조건 ☐ 암 분류표 ☐ 뇌·심 코드 범위 ☐ 해지환급금 표

30초 화법 카드 6장 — 외워서 나가는 한 줄

한 번에 모든 걸 전달하기보다, 하나라도 꼭 기억시키고 움직이게 만드세요

생존 vs 사망

"83세까지 사는 건 기본값이에요. 문제는 마지막 18년을 어떤 돈으로 버티느냐죠."

좁은 담보

"뇌졸중 4명 중 3명은 뇌출혈이 아니라 뇌경색이에요. 고객님의 증권은 4명 중 1명만 봅니다."

금리

"예금이 3.4%인데 보험 공시이율은 2.5%예요. 그것도 사업비 떼고요. 저축은 저축답게 하세요."

최초 1회한

"이 13개 중에 제일 먼저 걸리는 하나만, 딱 한 번 나와요. 저희는 각각 나옵니다."

관리

"생보 설계사 10명 중 6명이 1년 안에 그만둡니다. 이 복잡한 상품, 누가 대신 만져 주죠?"

재배치

"더 내시라는 게 아니에요. 같은 30만원을 죽어야 나오는 돈에서 아플 때 나오는 돈으로 옮기는 거예요."

★ 미션 ★ — 강의로 끝나면 그냥 「좋았던 교육」으로 끝납니다

오늘 배운 것을 이번 주 안에 현장에서 한 번 쓰는 것이 이 교안의 목표입니다

미션 1

증권 1장 해부

고객 생보 증권 1장을 가져와 상품명 해부 + 4분면 매핑 + 빈 방 3개 적기

미션 2

왜그그 롤플레이

2인 1조. 「왜? → 그 밖에 또? → 그래서!」 5분 롤플레이, FP 발화 30% 이내

미션 3

보험료 다이어트표

고객 1명의 BEFORE/AFTER 재배치표 작성 (당사 전산 견적 활용)

미션 4

30초 화법 녹음

6장 중 2장을 골라 30초 녹음, 조별 공유

🚩 「선택과 집중」: 움직임이 보이는 FP는 깊이 있게 서포트해 성공사례를 만들고, 본부 전체에 공유합니다. 문화는 사례에서 나옵니다.

07

만기까지 — 사망보장 vs 생존보장

생보는 만기(사망)까지 딱 한 번, 메리츠는 만기(100세)까지 아플 때마다 매년 다시



「만기」라는 같은 단어, 완전히 다른 두 그림

종신보험의 만기는 「사망」입니다. 메리츠 The건강한의 만기는 「100세」이고, 그 사이 매년 치료비 한도가 새로 열립니다.

생보 종신보험 1억

1억 × 1회 (죽어야 나옴)

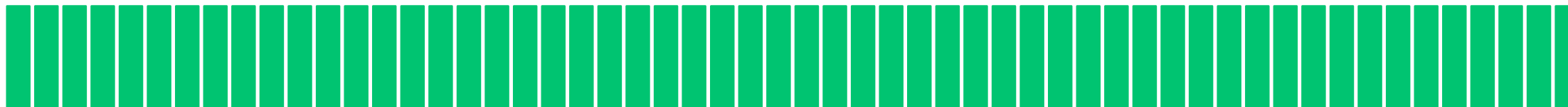
44세 가입

사망 시 ↑

살아 있는 56년 동안 이 보험에서 나오는 치료비: 0원 (선지급형은 나열 질병 중 첫 번째 1회에 한해 사망보험금을 당겨 씀)

메리츠 The건강한 · 통합치료비 5종

연 3억 4,000만원 한도 × 매년 새로 (최대 56회)



44세

72세

100세 만기

막대 하나 = 보험연도 하나. 암 1억 · 암II(비급여) 7천 · 특정순환계 1억 · 주요손상 3천 · 암전후·양성신생물 4천 — 담보별 연간 한도가 해마다 리셋됩니다. 진단비는 최초 1회, 통합치료비는 치료받을 때마다.

출처: (무)메리츠 The건강한 5.10.5 보장보험2607(3.0) 가입제안서(2026.9.15 발행, 44세 여, 20년납 100세만기, 월 669,590원) — 예시 금액은 약관·심사 기준에 따라 달라질 수 있음

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

통합치료비란 — 진단금과 별개로, 「실제 받은 치료」 항목마다 지급

검사 → 주요치료 → 수술 → 재활, 치료 단계마다 정해진 금액이 나옵니다. 진단비를 이미 받았어도 따로.

암 통합치료비(기본형)

1억

검사·수술·항암약물·방사선·비급여 표적/면역/로봇/양성자·
통증안화·재활

암 통합치료비II (비급여·상급종합)

7,000만

비급여 암수술 750만/회, 표적·면역·양성자 각 2,000만/연

특정순환계질환 통합치료비

1억

뇌출혈·뇌경색·심근경색·협심증·부정맥·심부전 등 52개 질병군

특정순환계질환(주요손상및질환)

3,000만

고혈압·판막·경막·두개내손상 등 40개 질병군 — 위와 겹치지
않게 보완

암전후관련 특정질환·양성신생물

4,000만

암 전후의 검사·마취·중환자실·양성종양 수술(1~5종) 등

연간 한도 합계 3억 4,000만원 — 해마다 새로 적용, 담보별 한도는 각각. 통합치료비 5종 월 보험료 합계 82,163원(위
설계 기준)

🔄 지급 규칙 4가지

- 검사·주요치료: 항목별 연간 1회한
- 수술: 수술할 때마다 (1회당)
- 재활: 입원·외래 1일 1회 (연 15~20회)
- 연간 한도는 보험연도마다 새로 시작
- 계약 후 1년 미만은 50% 감액
- 진단비(최초 1회)와 별개로 지급

출처: (무)메리츠 The건강한 5.10.5 보장보험2607(3.0) 가입제안서(2026.9.15 발행, 44세 여, 20년납 100세만기, 월 669,590원) — 예시 금액은 약관·심사 기준에 따라 달라질 수 있음

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

암 통합치료비(기본형) 1억 — 무엇을 받으면 얼마가 나오나

연간 총 지급한도 1억원. 항목별 금액은 계약 1년 경과 후 기준.

구분	통합치료항목	지급횟수	지급금액
검사	내시경·MRI·PET·특정단일유전자검사 / 초음파·CT / 특정생검 조직병리 / 특정 NGS 유전자패널	연간 1회한	5만 / 10만 / 20만 / 100만
주요치료	암(유사암 제외) 수술 / 유사암 수술	수술 1회당	1,000만 / 200만
주요치료	항암방사선치료 / 항암약물치료 / 항암세기조절방사선	연간 1회한	각 1,000만 (기타피부암·갑상선암 200만)
비급여	다빈치로봇 수술 / 특정암 로봇수술	연간 1회한	1,000만 / 200만
비급여	표적항암약물허가치료 / 특정면역항암약물허가치료 / 항암양성자방사선치료	연간 1회한	각 3,000만
통증완화	암 특정통증완화치료(급여)	연간 1회한	50만
재활	입원·외래 암 재활치료(급여)	각 1일 1회, 연 20회	2만
합계	연간 총 지급액 한도	매년 새로	1억원

+ 암 통합치료비II (비급여) 7,000만

- 비급여 암 수술 750만 / 수술 1회당
- 비급여 다빈치로봇 750만 / 연
- 표적·면역·양성자 각 2,000만 / 연
- 연간 한도 7,000만 (1년 미만 3,500만)

합치면

표적항암 1종: 기본형 3,000만 + II 2,000만 + 10년갱신
표적항암약물허가치료비 1억 = 연 1억 5,000만원대. 항암을 해마다 계속하면 해마다 다시.

출처: (무)메리츠 The건강한 5.10.5 보장보험2607(3.0) 가입제안서(2026.9.15 발행, 44세 여, 20년납 100세만기, 월 669,590원) — 예시 금액은 약관·심사 기준에 따라 달라질 수 있음 · 53p 암 통합치료비(기본형)·43p 암 통합치료비II 특약 안내사항

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

사례 ① 폐암 — 진단부터 표적항암까지 4억 6,155만원, 그리고 이듬해 또

진단 → 흉강경 폐절제 → 표적·면역(키트루다) 항암 → 상급종합 1인실 입원. 어느 담보에서 얼마가 나오는지.

STEP 1 검사·진단

흉부 CT · PET · 조직검사

7,035만

통합암진단비 5,000 + 암진단맞치료비II 2,000 + 암
통합치료비 검사 35

STEP 2 수술

흉강경 폐엽절제술

4,140만

암수술비 1,000 + 수술비III 5종 1,000 + 6종 1,000 +
암 통합치료비 수술 1,000 + 상급종합 질병수술비 100
...

STEP 3 항암

표적항암 → 키트루다(면역·비급여)

3억 4,760만

10년갱신 표적항암약물허가치료비 1억 + 암
통합치료비 표적 3,000·면역 3,000 + 암II 표적
2,000·면역 2,000 + 26종 항암약물치료비 4,000 ...

STEP 4 입원

상급종합 1인실 10일

220만

상급병실 1인실 일당 110 + 종합병원 일당 100 +
질병입원일당 10

합계 4억 6,155만원 (진단비 7,000만 포함). 종신보험 1억은 이 고객이 '죽어야' 나옵니다.
이 고객은 살았고, 다음 해에도 항암을 합니다.

 반복(연 1회): 표적항암 1종 최초 2억 760만 → 이듬해 2억 750만 → 그 다음 해도.
면역+표적 병용이면 3억 3,760만 → 매년 3억 3,750만. 한도는 해마다 새로.

출처: (무)메리츠 The건강한 5.10.5 보장보험2607(3.0) 가입제안서(2026.9.15 발행, 44세 여, 20년납 100세만기, 월 669,590원) — 예시 금액은 약관·심사 기준에 따라 달라질 수 있음 · 45p 암 세부보장, 51p 사례로 보는 치료비 보장 (담보 조건부는 보수적으로 계산)

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

조합의 힘 — 암 통합치료비 1억 + 암전후관련·양성신생물 통합치료비 4,000만

암이 되기 「전」의 혹·결절·용종과 암 치료 「중」의 마취·중환자실·검사까지. 두 담보가 시간축을 이어 붙입니다.

암 전 — 양성신생물

갑상선 결절, 유방 양성종양, 자궁근종, 대장 용종, 담석...

암전후·양성신생물 통합치료비: 특정생검·내시경·천자 30만, 골수검사 50만, 수술 1종 5만~5종 1,000만, 전신마취(6h↑) 500만

암 진단·치료 중

수술·항암·방사선·비급여 신의료기술

암 통합치료비 1억 + II 7,000만: 수술 1,000만/회, 항암 3,000만/연, 로봇 1,000만...

암 치료 중 합병증·집중치료

중환자실, 지속적신대체요법, 부분체외순환, 저체온요법

암전후 통합치료비: 중환자실 100만, CRRT 500만, 부분체외순환 2,000만, 인공호흡기 200만

다빈도 질환 수술 시뮬레이션 (제안서 50p, 상급종합 기준 지급 합계)

질환	지급 합계	그중 암전후·양성신생물 통합치료비
갑상선 결절 (D34)	620만	150만
유방 양성종양 (D24)	315만	5만
자궁근종 (D25)	430만	5만
담석증 (K80)	510만	40만

💬 "고객님, 암 진단비는 암이 「확정」돼야 나오죠. 그 전에 혹을 떼고, 조직검사를 하고, 결절을 지켜보는 과정은 누가 내나요? 이 담보는 「암이 되기 전」부터 「암 치료 중 중환자실」까지 이어 붙입니다."

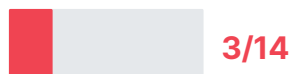
질병코드 지도 — 진단비는 '좁고 한 번', 통합치료비는 '넓고 매년'

뇌혈관 질병코드 14개 · 심장·혈관 질병코드 72개 중, 각 담보가 몇 개를 보장하나

🧠 뇌혈관 질환 — 14개 코드

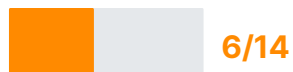
뇌출혈 진단비

I60~I62 · 생보 종신·CI·GI 기준



뇌졸중 진단비

I60~I63 · I65 · I66



뇌혈관질환 진단비

I60~I69 전체 · 3,000만 가입



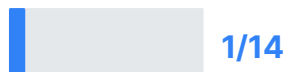
특정순환계질환 통합치료비

1억 가입 · 뇌출혈·뇌경색·경증 뇌혈관질환 등



주요손상및질환 통합치료비

3,000만 가입 · 두개내손상 등



두 통합치료비 합산

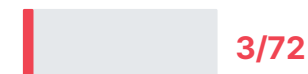
서로 겹치지 않아 79% 커버



❤️ 심장·혈관 질환 — 72개 코드

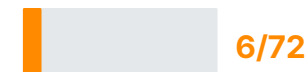
급성심근경색 진단비

I21~I23 · 생보 종신·CI·GI 기준



허혈성심장질환 진단비

I20~I25 · 협심증 포함 · 3,000만 가입



산정특례 진단비(심장)

I05~I51 · Q20~Q26 등



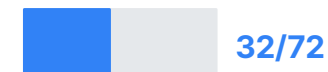
특정순환계질환 통합치료비

1억 가입 · 순환계 52개 질병군



주요손상및질환 통합치료비

3,000만 가입 · 고혈압·판막·경막 등



두 통합치료비 합산

서로 겹치지 않아 94% 커버



출처: (무)메리츠 The건강한 5.10.5 보장보험2607(3.0) 가입제안서(2026.9.15 발행, 44세 여, 20년납 100세만기, 월 669,590원) — 예시 금액은 약관·심사 기준에 따라 달라질 수 있음 · 47p 뇌·심혈관 질병코드 지도 (색칸 = 보장 질병, 회색 = 비대상)

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

사례 ② 뇌경색·심근경색 — 진단비 3,000만이 아니라 「치료할 때마다 1억」

특정순환계질환 통합치료비 1억: 혈전용해 2,500만 · 수술 1회당 2,000만 · 부분체외순환 2,000만 · 중환자실 2,000만 — 연 1억 한도, 매년 리셋

치료 경로	모든 병원	상급종합병원	수술할 때마다 (반복)
뇌경색 · 혈전용해제(tPA)만	3,500만	3,500만	—
뇌경색 · 혈전용해 + 기계적 혈전제거	1억 3,640만	1억 3,740만	7,740만
뇌동맥류 · 스텐트·코일 색전술	7,640만	7,740만	7,740만
뇌출혈 · 개두 수술	1억 40만	1억 140만	1억 140만
심근경색 · 혈전용해 + 혈전제거	1억 240만	1억 340만	4,340만
협심증·심근경색 · 관상동맥 스텐트(PCI)	4,240만	4,340만	4,340만
관상동맥 우회술 · 심장 개흉수술	9,040만	9,140만	7,140만

※ 진단금은 최초 1회 · 치료 금액은 진단금을 뺀 순수 치료보장액 (제안서 46p). 주요손상및질환 통합치료비 3,000만은 별도 한도로 추가.

제안서 51p 사례

뇌경색: 검사 4,015 + tPA 3,500 + 혈전제거 1억 140 + 중환자실 2,104 = 1억 9,759만

급성심근경색: 진단 4,010 + 스텐트 4,240 + 중환자실 2,042 + 재활 20 = 1억 312만

 재발 25.3%(뇌졸중, 질병관리청 2023). 두 번째 뇌경색이 와도 통합치료비는 다시 1억 한도. 생보 선지급형은 첫 번째로 끝.

출처: (무)메리츠 The건강한 5.10.5 보장보험2607(3.0) 가입제안서(2026.9.15 발행, 44세 여, 20년납 100세만기, 월 669,590원) — 예시 금액은 약관·심사 기준에 따라 달라질 수 있음 · 37p 특정순환계질환 통합치료비, 46p 뇌혈관·심혈관 보장, 51p 사례

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

44세 여성의 56년 — 만기까지 사망보장 1억 vs 만기까지 생존보장

같은 사람, 같은 병력. 제안서 사례 금액을 시간축에 올려 봅니다 (예시).

시점 · 사건	생보 종신 1억 (사망 시)	메리츠 The건강한 (생존 시)
52세 폐암 진단·수술·표적항암	0원	4억 6,155만
53세 표적항암 2년차 (연 1회 반복)	0원	2억 750만
68세 뇌경색 · tPA + 혈전제거 · 중환자실	0원	1억 9,759만
75세 급성심근경색 · 스텐트	0원 (GI 선지급형이면 첫 GI 질병 1회 8,000만)	1억 312만
83세 사망 (기대수명 86.6세 기준 예시)	1억	정기 사망담보 설계 시 지급 (책임기간 설계에 따름)
살아서 받은 돈 합계	0원	9억 6,976만원 + 진단비·수술비·입원일당

💰 보험료로 보면

- 생보 종신 1억(40대) 월 30만원대 → 20년 7,200만 납입, 사망 시 1억
- 메리츠 통합치료비 5종만: 월 82,163원 → 연 3.4억 한도
- 제안서 풀 설계(151개 담보): 월 669,590원, 총납입 2억 173만원 — 한 해 통합치료비 한도(3.4억)가 총납입액보다 큼

🛡️ 납입면제: 암·뇌졸중·급성심근경색·말기 폐/간/신·양성뇌종양·재생불량성빈혈·당뇨합병증·80% 후유장애 시 이후 보험료 면제 (제안서 9p)

출처: (무)메리츠 The건강한 5.10.5 보장보험2607(3.0) 가입제안서(2026.9.15 발행, 44세 여, 20년납 100세만기, 월 669,590원) — 예시 금액은 약관·심사 기준에 따라 달라질 수 있음 · 금액은 제안서 45·46·51p 사례 합산 예시, 실제 지급은 약관·심사 기준

세일즈혁신TF 이현수 · 본 자료는 교육용으로 고객 교부·배포 및 온라인 게시가 불가하며, 계약의 세부사항은 약관을 따릅니다.

Part 7 정리 — 「만기까지」 화법 4문장

생보 증권 앞에서 통합치료비를 꺼내는 순서

1 "고객님 종신보험 만기가 언제예요?" → "...사망이요"

만기가 사망이면, 살아서 아플 때 이 보험에서 나오는 돈은 0원이라는 뜻입니다. 그걸 고객 입으로 말하게 하세요.

2 "저희는 만기가 100세이고, 그 사이 매년 한도가 새로 열려요"

통합치료비 5종 연 3억 4천만원. 검사·수술·항암·중환자실·재활, 치료받은 항목마다. 재발해도 다시.

3 "뇌출혈 3개 코드 vs 뇌·심장 79개 코드"

생보 증권의 뇌출혈(3/14)·급성심근경색(3/72)과 통합치료비 조합(11/14 · 68/72)을 코드 지도로 보여 주세요.

4 "암은 살아서 비용을 치르는 병입니다"

폐암 사례 4억 6천 + 이듬해 2억. 5년 생존율 73.7% 시대, 죽어야 나오는 1억보다 살아서 매년 나오는 치료비가 보험입니다.

 고객 앞에서는 가입제안서 44p 「보장 한장요약」 → 47p 「질병코드 지도」 → 51p 「사례로 보는 치료비」 순서로 넘기세요. 이 교안의 슬라이드는 그 세 장을 설명하는 대본입니다.

오늘 배운 것 총정리

네 문장만 남기세요

1

생명보험은 이름만 보아도 상품 특징과 비용 구조를 알 수 있다

무배당·통합·변액·유니버설·CI·종신 = 단어 하나가 비용 하나. 「중대한」과 「최초 1회한」이 단서조항의 핵심.

2

사망보장과 생존보장 중 무엇을 원하는지 「왜그그」로 물으면 고객에게 맞는 보장이 나온다

사망은 책임기간만큼 정기·복층으로, 생존은 넓은 3대 진단비·수술·입원·간병으로, 책임은 배상·운전자로.

3

2026년 통계는 우리 편이다

유병기간 18년, 뇌졸중 76% 뇌경색, 예금 3.4% vs 공시이율 2.5%, 생보 정착률 38%, 해약 36.5조 — 숫자로 말하면 설득이 아니라 확인이 된다.

4

만기까지: 사망보장 1회 vs 생존보장 매년

종신보험의 만기는 사망. 메리츠 통합치료비는 100세 만기까지 매년 3억 4천만원 한도가 다시 열리고, 뇌·심장 코드도 3개에서 79개로 넓어진다.

 통계는 매년 갱신됩니다: 사망원인통계(9월), 생명표(12월), 암등록통계(12~1월), 심뇌혈관 발생통계(12월), 금감원 판매채널 효율(4월). 출처 페이지를 기준으로 연 1회 업데이트하세요.

우리가 먼저 다가가야 합니다

생보 증권은 「위기」가 아니라 「가장 좋은 대화 소재」입니다.
고객이 산 것은 상품이 아니라 「평생 도와줄 전문가」였습니다. 그 자리를 우리가 채웁니다.

안 된다 하지 말고!

아니라 하지 말고!

긍정적으로, 힘찬 하루 시작!

참고 통계 · 출처 (2026년 9월 17일 기준)

모든 수치는 공식 발표 자료 기준이며, 언론 보도로 교차 확인했습니다. 강의 전 최신 발표분으로 갱신하세요.

분야	자료	발표
사망원인	통계청 「2024년 사망원인통계」 (2025년 자료는 2026.9 말 발표 예정)	2025.9.25
기대수명·건강수명	국가데이터처 「2024년 생명표」	2025.12.3
고령화	행정안전부 주민등록 인구통계 / 통계청 장래인구추계 / 2025 인구주택총조사	2026.1 / 2023.12 / 2026.8
암	보건복지부·중앙암등록본부 「2023년 국가암등록통계」	2026.1.20
뇌·심장	질병관리청 「2023 심뇌혈관질환 발생통계」 / 심평원 진료현황	2025.12.31 / 2022~2020
의료비·간병·요양	건강보험통계연보 2024 / 건보공단 생애의료비 연구 / 2025 장기요양 통계연보 / 국회입법조사처	2025.11 / 2025.12 / 2026.6
연금·빈곤	국민연금공단 / OECD Pensions at a Glance 2025	2025 / 2025.11.27
금리	한국은행 금통위(2026.7.16 / 8.27) / 은행연합회 / 금감원 평균공시이율 고시	2026.8~9 / 2025.12
보험산업	보험연구원 「2026년 보험산업 전망」 / 금감원 「2025년 판매채널 영업효율」 / 금감원 소비자경보	2025.10.21 / 2026.4.29 / 2025.12.18
단기납·해약·제3보험	보험저널·연합뉴스·파이낸셜뉴스·머니투데이·한국경제·서울경제 등 2024~2026 보도	2024.1~2026.9
가계	한국은행 가계신용(2026 2Q) / 국가데이터처 소비자물가(2026.8)	2026.8.19 / 2026.9.2
메리츠 상품(Part 7)	(무)메리츠 The건강한 5.10.5 보장보험2607(3.0) 가입제안서 — 통합치료비 특약 안내·질병코드 지도·치료비 사례	2026.9.15 발행

※ 작성: 메리츠화재 세일즈혁신TF 이현수 · 2026년 9월 기준 통계·규제 반영